

极端断医家庭医疗手册

Austere Home Medical Field Guide - 2 名成人 + 1 只猫 | v17 普通人 + 实物 IFAK + 环境卫生版

用途：给没有医学背景的家庭成员在“断网、断电、长期无法获得医疗支持”时使用。核心逻辑不是“看到症状就吃抗生素”，而是：先排除致命急症 -> 判断更像哪一类疾病 -> 先做支持治疗 -> 只有在症候群高度匹配且已经预先处方/授权时使用 Rx。
儿童/婴儿禁区：严禁将本手册的成人用药逻辑、成人剂量或成人给药间隔按比例自行折算用于儿童或婴儿。

使用顺序 / How to use this guide

- 1. 先看“P0 紧急情况”：气道、呼吸、循环、大出血、过敏性休克、严重脱水、意识异常。
- 2. 再用“0. 普通人 10 分钟快速判断训练”确定症候群和严重程度，然后进入呼吸/咽喉、胃肠、泌尿、皮肤/伤口、过敏/哮喘章节。
- 3. 只判断“症候群”，不要试图在家精确鉴定病原体。没有检测时，很多病毒病和细菌病不能仅凭颜色或感觉区分。
- 4. Rx 抗生素/抗病毒药只按事先由医生确认的 预设用药单 使用；不随意叠加两种抗生素。
- 5. 每 4-8 小时记录体温、心率、呼吸、血压/SpO2（如果有）、尿量、症状趋势和已用药。

个人信息 / Personal profile

成人 A / Adult A	
基本资料	姓名: _____ DOB: _____ 体重: _____ kg
严重药物过敏	药物过敏: _____
关键病史	肾/肝病、妊娠、抗凝/心律问题: _____

成人 B / Adult B	
基本资料	姓名: _____ DOB: _____ 体重: _____ kg
严重药物过敏	药物过敏: _____
关键病史	肾/肝病、妊娠、抗凝/心律问题: _____

药箱优先级 / Priority

法律与使用声明见第 2 页；目录见第 3 页；P0 紧急情况从第 4 页开始。v17 新增：成人/儿童用药红线与长期处方药中断预案、茶苯海明（Gravol）、临时补牙材料、Steri-Strips + 复方安息香酊、重力净水器前置过滤、90 天个人长期药库存目标、Rx 中等强度外用激素及联合/错峰镇痛安全卡。

层级	代表物品/药物	原则
P0 - 立即救命	止血带/压缩纱布（另配止血纱布时可用）、口服补液盐（ORS）、肾上腺素自动注射器（EpiPen）、气道/呼吸支持、撤离方案	延误会在分钟到小时内造成死亡或不可逆损害
P1 - 核心	核心抗感染药、奥司他韦、昂丹司琼、沙丁胺醇、对乙酰氨基酚、质子泵抑制剂（PPI）	高概率场景 + 对生存/行动能力影响大
P2 - 扩展	甲硝唑、头孢氨苄、泼尼松、法莫替丁/海藻酸盐、阿苯达唑、外用药	补足特定场景，避免为“全面”堆重复药

本手册内“OR”=二选一；“+”=需要同时联合。出现多个抗生素名称时，不代表全部一起吃。

当前药箱更新：已将肾上腺素自动注射器（EpiPen 0.3 mg）列入 P0 核心急救库存，用于严重过敏性休克；西替利嗪、泼尼松和沙丁胺醇只能辅助，不能替代肾上腺素。阿苯达唑片继续保留，用于特定常见肠道蠕虫感染。

极度危险与法律/使用声明 | Critical Risk, Legal & Use Notice

使用前完整阅读。继续阅读、下载或使用仅表示已知悉本页内容；是否形成有约束力的协议、免责或责任限制，以适用法律与具体事实为准。

法律效力边界：任何声明都不能自动创造“绝对免责”。本声明仅在适用法律允许的最大范围内生效；不能排除法律明确规定不得排除的责任，也不能预先免除任何刑事、监管或法定义务。

1. 非医疗专业身份与资料性质 (Non-Medical Professional Status)

- 本手册及其衍生文件是基于公开的严酷环境医学、WFA/TCCC、公共卫生与药物资料整理的个人灾备学习资料，不替代医生、药师、护士或法定急救人员。
- 本手册不针对具体个人作诊断、开具处方或建立个体化治疗方案；单纯下载、阅读、转发或分发本资料，不当然建立医患、受托或专业服务关系。
- **【儿童/婴儿绝对禁区】本手册按成人灾备场景编写。严禁将成人用药逻辑、剂量或给药间隔按体重、年龄或比例自行折算用于儿童或婴儿。**

2. 极端适用场景限制 (Strictly Limited Scope of Use)

- 仅用于重大地震、战争、极端暴雪、长期停电/断网等，使专业医疗、急救呼叫和安全转运在现实上长期不可获得的严酷环境。
- 只要专业医疗、药师咨询、急救呼叫、远程医疗或安全转运仍现实可行，应优先使用这些服务；灾害环境与常规医疗环境的风险收益不同。

3. 处方药、器械与法律边界 (Prescription Drugs & Legal Boundaries)

- 抗生素、抗病毒药、肾上腺素自动注射器（EpiPen）及其他处方药/器械，必须依所在地法律合法取得、储存和使用；本手册不提供非法获取或规避监管的方法。
- “Rx 预设用药单”只是与有资格医生/药师沟通的模板；剂量、疗程、禁忌、过敏史和个体适用性应在灾前核准。针刺减压等侵入性操作仅限法律允许、人员受训且确有适应证时按正式训练执行。

4. 风险自担与责任限制 (Assumption of Risk & Limitation of Liability)

- 严酷环境医学天然具有高风险；即使严格按决策树执行，也可能出现误判、药物不良反应、感染进展、永久伤残或死亡。
- 本资料按“原样（As-Is）”提供。在适用法律允许的最大范围内，不对完整性、绝对准确性、实时性或特定用途适用性作保证；作者、贡献者和分发平台的责任仅限于法律允许限制的范围。使用者必须持续复评，事实与手册假设不一致时停止机械套用。

5. 许可、反篡改与版本校验 (CC BY-NC-ND 4.0 & Integrity Verification)

- 对作者有权许可的原创内容采用 CC BY-NC-ND 4.0；第三方引用、商标、图片等仍受其原有权利约束。
- 允许署名、非商业地复制和分发未修改版本；私人可制作修改副本，但不得按本许可公开传播改编版本。修改版应标为“非官方版”，不得使用官方版本号、校验值或“原版/官方版”造成混淆。
- 完整许可效力以 Creative Commons BY-NC-ND 4.0 官方 Legal Code 为准；“开放许可”不等同于软件意义上的“开源”。

SHA-256 校验：官方发布包应另附 SHA256SUMS.txt；不要把 PDF 自身哈希写进 PDF 正文，否则写入后文件变化、哈希立即失效。以同一发布包/官方发布页提供的独立校验文件为准。

版本标识：v17 | 发布者标识：@JZyy | 本声明与手册正文应作为同一完整文件保存。

目录 / Table of Contents

快速找到“判断疾病 -> 选择处理 -> 查药物 -> 查处方预案”的对应章节

法律与使用声明 / Legal & Use Notice	2
1. P0 紧急情况：先保命，再谈诊断	4
0. 普通人 10 分钟快速判断训练	5
0A. 常见症状 → 最可能问题 → 首选处理	6-8
0B. 如何“对症下药”而不是“见症状就堆药”	9
0C. 症状决策树 + 药物搭配	10-20
2. 发热、咳嗽、鼻塞、咽痛：怎么区分	20
3. 慢性咽喉炎：治疗、康复与预防	21-22
4. 胃肠道：呕吐、腹泻、胃痛、黑便	23-24
5. 泌尿、牙源、皮肤与伤口	25
6. 过敏、哮喘、疼痛与常见对症处理	26
6A. 普通人急救核心技能（含实际 IFAK 套装）	27-29
6B. 外伤处理：出血/伤口/骨折/胸腹/烧伤/眼伤	30-35
6C-6D. 环境急症 + 普通人外伤“不要做”/复评	36-37
6E-6F. 离线防感染/女性卫生与非创伤性眼科急症	38-39
7. 药物总表 A：抗感染	40-42
8. 药物总表 B：支持/对症与急救	43-45
9. 条件性/舒适性模块 + 常用 OTC 成人参考	46-47
10. 疾病 - 药物搭配速查	47
11A-11B. Rx 预设用药单：抗感染 + 急救/支持/禁忌	48-51
12. 储存、库存、观察记录与猫模块	52-53
13. 依据与离线备注	53-54

目录说明：0A、0B、0C 均属于“普通人快速判断”体系；0C 内部按 0C-1 至 0C-12 连续编号。

1. P0 紧急情况：先保命，再谈诊断 / Immediate Life Threats

灾难性出血 Catastrophic bleeding	
怎么识别	血液喷射/持续涌出；短时间浸透敷料；截肢/深部创伤
立即处理	直接强压 -> 深伤口 packing -> 肢体危及生命出血用正规止血带并记时间；平卧保暖
关键禁区	不要反复掀开敷料；不要用口服“止血药”替代机械止血

过敏性休克 Anaphylaxis	
怎么识别	突然喉舌肿、喘鸣/呼吸困难、晕厥/低血压，或皮肤症状 + 呼吸/循环/胃肠多系统反应
立即处理	立即使用肾上腺素自动注射器（EpiPen）：橙色端贴大腿外侧，可隔衣注射，按装置说明压住约 3 秒；同时平卧/保暖并启动求救撤离。若 5-15 分钟后仍无改善或恶化，且有第二支，可再次使用。喘鸣时沙丁胺醇仅辅助
关键禁区	没有可用的口服药能替代肾上腺素逆转严重过敏性休克；泼尼松起效慢，也不能替代

严重呼吸困难 Respiratory distress	
怎么识别	说不完整句子、明显胸凹/使用辅助呼吸肌、紫绀、SpO2 持续低或意识改变
立即处理	保持气道、舒适体位、按既往哮喘预案用沙丁胺醇；若符合过敏性休克，立即优先使用肾上腺素自动注射器（EpiPen）并同时启动求救/撤离
关键禁区	不要靠镇静药“让病人安静”；严重肺炎/哮喘可能需要氧气/高级气道

上消化道大出血 Upper GI bleed	
怎么识别	吐鲜血/咖啡渣样物 + 黑色柏油样便；头晕、冷汗、脉快、血压下降
立即处理	停止活动、平卧保暖；反复呕吐侧卧；清醒且可吞咽时 质子泵抑制剂（PPI）仅作为辅助；尽一切办法撤离
关键禁区	禁 布洛芬（Ibuprofen）/萘普生（Naproxen）；阿莫西林（Amoxicillin）不止血；不要把 次水杨酸铋（Pepto-Bismol）当止血药

严重脱水/休克 Severe dehydration/shock	
怎么识别	持续呕吐/腹泻 + 少尿、直立晕、口干、心率快、意识异常
立即处理	能喝则 口服补液盐（ORS）小口频饮；呕吐时可按预案 昂丹司琼（Ondansetron）后继续 口服补液盐（ORS）
关键禁区	无法保留液体、意识改变或休克时，口服补液能力已经不足

脑卒中/急性冠脉综合征 Stroke / ACS	
怎么识别	新发单侧无力、口角歪、语言异常；或压榨性胸痛伴冷汗/恶心/放射痛
立即处理	记录发病时间，减少活动，立即寻找任何救援/转运；阿司匹林（Aspirin）仅在医生预先制定的 ACS 方案且无出血禁忌时使用
关键禁区	疑似脑出血/消化道出血时不要自行使用 阿司匹林（aspirin）

感染可能进入“危险区”的表现 / Escalation signs

- 意识变差、无法进食饮水、进行性少尿、呼吸明显加快、持续低血压或脉搏越来越快。
- 皮肤感染快速扩散、出现紫黑/坏死、水疱，或“疼痛远大于外观看起来的程度”。
- 咽喉痛伴流口水、张口困难、含糊“热土豆音”、颈部明显肿胀或呼吸困难。
- 发热伴颈强、严重头痛、紫癜样皮疹、意识异常。

0. 普通人 10 分钟快速判断训练 / 10-Minute Layperson Triage

目标不是在家“确诊所有疾病”，而是在没有检验/影像的情况下：先排除立即致命问题 -> 找出最可能的症候群 -> 选择最少且足够的药 -> 持续复评。任何时候病情与表格不吻合，都以危险信号和生命体征为先。

A. 第 1 分钟：先问“会不会马上死人？”

无反应/呼吸异常	
普通人怎么判断	叫不醒、只剩濒死喘息、没有正常呼吸
先做什么	按急救培训实施 CPR/AED；呼救/撤离
药物地位	药物不是第一步

灾难性外出血	
普通人怎么判断	喷射、持续涌血、敷料很快浸透
先做什么	直接强压；深伤口填塞；危及生命的肢体出血用正规止血带
药物地位	机械止血 > 任何口服药

严重呼吸困难	
普通人怎么判断	说不完整句子、明显用力呼吸、发绀、SpO2 持续低、意识改变
先做什么	保持气道、舒适体位；本人有沙丁胺醇预案时使用；尽快撤离
药物地位	若是过敏性休克，沙丁胺醇只能辅助

过敏性休克	
普通人怎么判断	喉舌肿、喘鸣/呼吸困难、晕厥/低血压，或快速出现多系统反应
先做什么	立即停止接触、平卧/保暖；马上使用肾上腺素自动注射器（EpiPen），并启动一切可用救援；喘鸣可按预案加用沙丁胺醇
药物地位	西替利嗪/泼尼松不能替代肾上腺素

休克/严重脱水	
普通人怎么判断	冷汗、四肢冷、心率很快、血压下降、意识差、明显少尿
先做什么	平卧保暖；若清醒且能吞咽且非活动性呕血，可小口口服补液盐（ORS）；持续恶化必须撤离
药物地位	口服补液盐（ORS）只适用于能安全口服的人

B. 第 2-4 分钟：量“6 个数”，看趋势比单次更重要

项目	大致参考（健康成人、海平面）	危险提示/如何理解
体温	$\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ 可视为发热	高热本身不能区分病毒/细菌；发热 + 意识异常/颈强/紫癜是危险组合
心率 HR	静息常见 60-100/min	持续 >120 、越来越快，尤其伴低血压/少尿/冷汗，提示循环压力大
呼吸频率 RR	静息常见约 12-20/min	持续 >24 要重视； ≥ 30 或伴说话困难/SpO2 下降属于高风险
血压 BP	看本人平时水平	收缩压 <90 mmHg 或进行性下降是危险信号；心率/收缩压 ≥ 1 仅作休克警示，不是诊断
血氧 SpO2	多数健康成人海平面约 95-100%	持续 $\leq 92\%$ 或比本人基线明显下降 + 呼吸困难，应视为高风险；冷手/指甲油会影响读数
意识/尿量	能正常对答；能规律排尿	新发嗜睡/混乱、8-12 小时几乎无尿或尿量明显下降，要考虑重症/脱水/休克

C. 第 5 分钟：先把问题放进“一个主系统”

- 鼻塞/流涕/咽痛/咳嗽 -> 呼吸道；先区分普通病毒、流感、链球菌咽炎、细菌性鼻窦炎和肺炎。
- 呕吐/腹泻/腹痛/黑便 -> 胃肠道；第一优先通常是补液和排除出血/急腹症。
- 尿频/尿急/尿痛 -> 泌尿；若再加高热、寒战、腰痛或呕吐，要按上尿路感染/肾盂肾炎看待。
- 红、肿、热、痛/脓液 -> 皮肤软组织；“有脓腔”和“没有脓腔”的治疗逻辑不同。
- 风团/瘙痒 -> 轻度过敏；如果出现喉舌肿、喘鸣、晕厥/低血压 -> 过敏性休克。
- 长期反复咽喉不适 -> 慢性咽喉问题；优先找鼻后滴流、反流、干燥、刺激物/清嗓习惯，而不是反复吃抗生素。

0A. 常见症状 -> 最可能问题 -> 首选处理 / Quick Pattern Recognition

表内“可能”不是实验室确诊。先看“怎么区分”，只有符合模式并且没有关键禁忌时才进入相应预设用药单。“OR” = 二选一；“+” = 需要时联合。

流涕 + 鼻塞 + 咳嗽/声音沙哑	
更像什么	普通病毒性上呼吸道感染
普通人快速区分	症状较弥漫；通常逐渐改善；咳嗽/流涕反而降低链球菌咽炎可能
首选药物/处理	休息、补液；对乙酰氨基酚 OR 布洛芬；不常规用抗生素

突然高热/寒战 + 全身酸痛 + 明显乏力 + 咳嗽	
更像什么	流感 A/B
普通人快速区分	“突然倒下”式发病比普通感冒更典型；流感季/同住者聚集发病支持
首选药物/处理	奥司他韦（越早越有价值）+ 对乙酰氨基酚 + 口服补液盐（ORS）

突发咽痛 + 发热 + 扁桃体渗出 + 颈前淋巴结痛，咳嗽很少	
更像什么	链球菌性咽炎可能
普通人快速区分	越符合上述组合越可疑；最好有快速检测/咽拭子；咳嗽/流涕明显更像病毒
首选药物/处理	医生预案：阿莫西林；疼痛可对乙酰氨基酚 OR 布洛芬

鼻窦症状 >10 天不改善；或高热 $\geq 39^{\circ}\text{C}$ 伴脓涕/面痛 3-4 天；或先好后坏	
更像什么	急性细菌性鼻窦炎可能
普通人快速区分	三个模式比“黄鼻涕”本身更重要
首选药物/处理	医生预案：阿莫西林/克拉维酸；鼻腔盐水；止痛退热

咳嗽 + 发热 + 气短/胸膜性胸痛 + RR 增快/SpO2 下降	
更像什么	肺炎综合征
普通人快速区分	比普通支气管炎多了呼吸困难、胸痛、低氧或明显全身病容；无 X 光时只能做临床判断
首选药物/处理	轻症预案：阿莫西林 OR 多西环素；有合并症的方案可为阿莫西林/克拉维酸 + 阿奇霉素/多西环素；按预案选择

咳嗽有痰，但无低氧/明显气促/胸痛	
更像什么	急性支气管炎，多数病毒性
普通人快速区分	黄/绿痰不能证明细菌感染
首选药物/处理	补液、退热止痛；有喘鸣且本人有处方可用沙丁胺醇；不常规用抗生素

长期咽干/异物感/反复清嗓，晨起重或饭后/躺下重	
更像什么	慢性咽喉刺激：鼻后滴流、LPR/GERD、干燥等
普通人快速区分	无急性高热；反复数周以上；与环境/饮食/鼻炎/清嗓相关
首选药物/处理	按第 3 章：补水、控制刺激物；鼻炎型用盐水/过敏管理；反流型生活方式 + 必要时质子泵抑制剂（PPI）；不反复吃抗生素

胃肠、泌尿、皮肤与寄生虫快速判断

水样腹泻，无血、无明显高热	
更像什么	急性非侵袭性腹泻
如何区分	核心问题通常是水电解质丢失
首选药物/处理	口服补液盐（ORS）为核心；需要控制症状时洛哌丁胺

血便或明显发热性腹泻	
更像什么	痢疾/侵袭性腹泻可能
如何区分	血便、高热、明显全身症状与普通水样腹泻不同
首选药物/处理	口服补液盐（ORS）+ 医生预案阿奇霉素；不要单独用洛哌丁胺压住症状

污染水后持续腹泻、腹胀、恶臭/油脂样便	
更像什么	贾第虫病可能
如何区分	常持续>1 周，脂肪便/腹胀明显
首选药物/处理	口服补液盐（ORS）+ 医生预案甲硝唑；阿苯达唑不是首选

尿痛 + 尿频 + 尿急，无高热/腰痛	
更像什么	单纯性膀胱炎可能
如何区分	症状集中在下尿路
首选药物/处理	医生预案：呋喃妥因 OR 复方磺胺甲噁唑

尿路症状 + 高热/寒战 + 腰/肋脊角痛 +/- 呕吐	
更像什么	肾盂肾炎/上尿路感染可能
如何区分	这是膀胱炎的“升级版”，可能快速恶化
首选药物/处理	不要依赖呋喃妥因；按专门肾盂肾炎预案并优先撤离/求援

红肿热痛扩散，无明显脓腔	
更像什么	非化脓性蜂窝织炎
如何区分	没有中央脓液/波动感
首选药物/处理	医生预案：头孢氨苄 OR 阿莫西林/克拉维酸

局部脓包/脓液/波动感	
更像什么	脓肿/化脓性皮肤感染
如何区分	“脓腔”最关键
首选药物/处理	充分引流/源控制 + 医生预案多西环素 OR 复方磺胺甲噁唑（按指征）

猫/狗/人咬伤后红肿热痛或深穿刺	
更像什么	咬伤感染
如何区分	猫咬手部尤其高风险
首选药物/处理	大量冲洗 + 医生预案阿莫西林/克拉维酸

夜间肛周剧痒，家庭成员也可能出现	
更像什么	蛲虫
如何区分	夜间更重；可见细小小白虫/透明胶带试验支持
首选药物/处理	阿苯达唑；同时做家庭卫生和 2 周后重复方案（按手册）

0B. 如何“对症下药”而不是“见症状就堆药”

一、选药顺序：从最小有效干预开始

- 第 1 层 - 支持治疗：补液、休息、伤口冲洗/覆盖、退热止痛、环境调整。很多病毒病和轻症只需要这一层。
- 第 2 层 - 针对性对症药：例如呕吐用昂丹司琼帮助口服补液；支气管痉挛按处方用沙丁胺醇；胃酸/溃疡症状用埃索美拉唑。
- 第 3 层 - 抗病毒：症候群高度符合流感时，按预案尽早使用奥司他韦。
- 第 4 层 - 抗生素：必须先找到“细菌感染模式 + 感染部位”。通常一次只选一个预案；只有手册明确写“+”时才联合。
- 第 5 层 - 源控制：脓肿需要引流、污染伤口需要冲洗、灾难性出血需要机械止血；这些不能用“更强的药”替代。

二、抗生素使用前的“4 个问题”

问题	如果答案是“否”	例子
1. 是否真的有细菌模式？	先不要吃抗生素	普通感冒、病毒性支气管炎、黄痰本身都不够
2. 能否判断感染部位？	不要用“万能广谱药”碰运气	肺、鼻窦、尿路、皮肤、牙源、肠道的首选药不同
3. 是否排除了关键禁忌？	换用预先批准的替代方案	严重青霉素过敏、肾病、妊娠、QT 延长、GI 出血等
4. 手册是否明确写了联合？	只用一个方案，不叠加	“OR” 只选一个；“+” 才同时使用

三、用药后怎么知道“正在好转”还是“治疗失败”？

场景	合理期待	失败/升级信号
口服补液盐（ORS）+ 昂丹司琼	数小时内更能喝进去、直立头晕减轻、尿量逐渐恢复	持续无法保留液体、意识变差、8-12 小时几乎无尿、循环恶化
沙丁胺醇	通常几分钟内喘鸣/胸闷应有明显缓解	需要越来越频繁使用、说话困难、SpO2 下降、无明显缓解 -> 高风险
奥司他韦	不是“吃一粒马上退烧”；目标是缩短/减轻流感并降低部分并发症风险	呼吸困难、胸痛、低氧、先好转后再次高热/恶化 -> 考虑肺炎/并发症
抗生素	很多感染在 48-72 小时内才看到趋势改善；不要因 1 天没退烧就自行叠加第二种	任何时间明显恶化、出现休克/低氧/意识异常；或 48-72 小时完全无改善 -> 重新判断病因/耐药/脓肿或需更高级治疗
埃索美拉唑	胃酸/反流症状通常不是即刻完全消失	吐鲜血、咖啡渣样物、黑色柏油便、晕厥 -> 不是“加倍胃药”能解决

四、普通人最容易犯的 8 个错误

- 把发热、黄痰、黄鼻涕自动等同于细菌感染。
- 把两种或三种抗生素一起吃，当作“覆盖更全面”。
- 把阿莫西林/克拉维酸当成所有感染的第一选择。
- 有血便/高热性腹泻时单独用洛哌丁胺把肠蠕动完全压下去。
- 出现黑便/呕血仍继续用布洛芬、萘普生等非甾体抗炎药（NSAIDs）。
- 把西替利嗪、泼尼松或沙丁胺醇当成过敏性休克的肾上腺素替代品。
- 看到脓肿只吃抗生素，却忽略引流/源控制。
- 症状稍好就随意停掉已启动的处方抗菌疗程，或因一天没好就随意换药。

给非医学背景使用者：当你不知道是哪一种病时，不要从“哪一种药最强”开始想；从“有没有生命危险 -> 主要症状在哪个系统 -> 哪个模式最吻合 -> 有没有禁忌 -> 最小有效方案”开始。

0C. 症状决策树 + 药物搭配 / Symptom Decision Trees & Medication Pairing

这一节是给没有医学背景的人使用的“第二层决策页”。流程固定为：先排除 P0 生命威胁 -> 找到最吻合的症候群 -> 选择最少且足够的处理 -> 只在明确写“+”时联合药物 -> 按时间复评。这里的“更像什么”是离线分诊，不等于实验室确诊。

0C-1. 呼吸道、咽喉与流感

普通病毒性上呼吸道感染 / Viral URI	
更像什么	普通感冒/病毒性上呼吸道感染
怎么判断	流涕、鼻塞、打喷嚏、咳嗽或声音沙哑较突出；通常逐渐改善。黄痰/黄鼻涕本身不能证明细菌感染。
先做什么	休息、饮水；发热/疼痛时用对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 无禁忌时布洛芬（Ibuprofen）。
药物搭配	需要时：西替利嗪（Cetirizine，过敏成分明显）+ 鼻腔盐水。
不要这样做	不要因为痰或鼻涕变黄就启动抗生素；急性支气管炎多数也不需要抗生素。
何时复评/升级	症状明显恶化、持续高热、出现气短/胸痛/低氧，或先好转后再次明显变差 -> 转入肺炎/细菌性鼻窦炎判断。

流感 A/B / Influenza	
更像什么	流感综合征
怎么判断	突然发病，发热/寒战、明显肌痛、头痛、乏力 + 咳嗽/咽部症状；流感季或同住者聚集发病更支持。
先做什么	尽早休息、隔离、补液；高风险或病情进展者不要等待检测才处理。
药物搭配	奥司他韦（Oseltamivir）+ 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen）+ 口服补液盐（ORS）；呕吐妨碍饮水时按预案加昂丹司琼（Ondansetron）。
不要这样做	奥司他韦不是普通感冒药，也不能治疗细菌性肺炎；不要同时为了“保险”启动抗生素。
何时复评/升级	发病 48 小时内抗病毒获益通常最大；若出现气短、胸痛、SpO2 下降、意识异常，或一度好转后再次高热恶化 -> 考虑继发肺炎/严重流感。

链球菌性咽炎可能 / Possible GAS pharyngitis	
更像什么	A 组链球菌性咽炎可能
怎么判断	突然咽痛 + 发热 + 扁桃体渗出/白点 + 颈前淋巴结痛，且咳嗽/流涕很少。能快速链球菌检测最好。
先做什么	补液、盐水漱口、镇痛退热；若检测阳性或按预设标准高度符合，进入抗菌方案。
药物搭配	阿莫西林（Amoxicillin）+ 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen），具体抗菌剂量/疗程按 Rx 预设页。
不要这样做	不要为了“更强”常规改用阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）；明显咳嗽、流涕、声音沙哑更偏病毒。
何时复评/升级	48-72 小时完全无改善、越来越难吞咽、流口水、张口困难、含糊热土豆音、颈部肿胀或呼吸困难 -> 重新判断深颈部感染/脓肿等。

急性细菌性鼻窦炎可能 / Possible ABRS	
更像什么	细菌性鼻窦炎模式
怎么判断	三个更有价值的模式：症状>10 天仍不改善；或≥39°C 高热伴脓涕/面痛持续 3-4 天；或感冒先好后坏。
先做什么	鼻腔盐水、补液、镇痛；症状不重且能可靠观察时可先观察。
药物搭配	阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）+ 鼻腔盐水 + 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen），抗菌疗程按 Rx 预设页。
不要这样做	不要仅凭黄/绿鼻涕用抗生素；阿奇霉素（Azithromycin）不是常规经验性首选。
何时复评/升级	眼周肿胀、视力改变、剧烈头痛、意识改变、颈强，或 48-72 小时治疗后仍明显恶化 -> 高风险并发症。

急性支气管炎 / Acute bronchitis	
更像什么	多数为病毒性急性支气管炎
怎么判断	咳嗽可有痰，但没有明显气促、胸膜性胸痛、低氧或局灶性肺部体征；有色痰不能证明细菌感染。
先做什么	休息、饮水、镇痛退热；有明确支气管痉挛/喘鸣且本人有预案时使用沙丁胺醇（Salbutamol）。
药物搭配	对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen）+ 补液；沙丁胺醇（Salbutamol）仅在喘鸣/支气管痉挛时。
不要这样做	常规不要使用抗生素。
何时复评/升级	心率≥100、呼吸频率≥24、体温≥38°C 并伴气促/低氧/胸痛，或病容明显 -> 重新评估肺炎。

社区获得性肺炎模式 / Community-acquired pneumonia pattern

更像什么	肺炎综合征
怎么判断	咳嗽 + 发热，同时出现气短、胸膜性胸痛、呼吸频率上升、SpO2 下降或明显病容。没有 X 光时只能做临床分诊。
先做什么	测 SpO2/呼吸频率/血压；补液和退热；尽可能寻找医疗支持。
药物搭配	无重要合并症且已预先授权：阿莫西林（Amoxicillin）OR 多西环素（Doxycycline）。有重要合并症且已预先授权扩大覆盖：阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）+ 阿奇霉素（Azithromycin）OR 多西环素（Doxycycline）。
不要这样做	不要把所有三种抗生素一起吃；普通急性支气管炎不应按肺炎方案治疗。
何时复评/升级	SpO2 持续 $\leq$ 92%（海平面附近）、RR $\geq$ 30、低血压、意识改变、无法口服，或 24-48 小时快速恶化 -> 高危；48-72 小时无任何改善 -> 重新判断/升级。

哮喘/支气管痉挛急性加重 / Bronchospasm

更像什么	支气管痉挛/哮喘样急性加重
怎么判断	喘鸣、胸闷、呼气困难，常有既往哮喘/喘鸣史；若同时喉舌肿、晕厥或多系统过敏，则按过敏性休克。
先做什么	舒适体位，监测 SpO2；按本人预设方案使用吸入药。
药物搭配	沙丁胺醇（Salbutamol）+（仅在医生预授权的急性加重方案中）泼尼松（Prednisone）。
不要这样做	如果符合过敏性休克，沙丁胺醇/泼尼松都不能替代肾上腺素自动注射器（EpiPen）。
何时复评/升级	沙丁胺醇后无明显改善、需要越来越频繁、说话困难、发绀、SpO2 下降或意识异常 -> 高危。

0C-2. 胃肠道、补液与腹泻

呕吐 + 脱水 / Vomiting with dehydration

更像什么	胃肠炎/其他原因导致的脱水风险
怎么判断	持续呕吐、口干、直立头晕、尿量减少；先排除呕血、剧烈局灶腹痛、腹膜刺激征、意识异常。
先做什么	小口频繁口服补液；一次不要灌大量液体。
药物搭配	昂丹司琼（Ondansetron）+ 口服补液盐（ORS），按预设剂量；能喝下后持续补液。
不要这样做	休克、意识差、活动性呕血时不要强行口服；不要把运动饮料当严重脱水时唯一补液方案。
何时复评/升级	数小时内应更能保留液体、直立头晕减轻、尿量开始恢复；8-12 小时几乎无尿、持续不能留液或意识变差 -> 升级。

急性水样腹泻 / Acute watery diarrhea

更像什么	非侵袭性急性腹泻更可能
怎么判断	水样便，无血、无明显高热；主要危险是水和电解质丢失。
先做什么	立即口服补液盐（ORS）；继续能耐受的进食。
药物搭配	口服补液盐（ORS）+ 洛哌丁胺（Loperamide，确有需要时）。
不要这样做	血便或明显发热时不要把洛哌丁胺作为单药；轻症不要自动用抗生素。
何时复评/升级	尿量下降、明显直立晕、持续呕吐、血便/高热、剧烈腹痛，或数日不改善 -> 重新分类。

血性/发热性腹泻 / Dysentery or febrile diarrhea

更像什么	侵袭性腹泻/痢疾可能
怎么判断	血便，或腹泻伴明显发热、全身症状；比普通水样腹泻更危险。
先做什么	口服补液盐（ORS）优先；观察循环/尿量。
药物搭配	按预授权方案：口服补液盐（ORS）+ 阿奇霉素（Azithromycin）；洛哌丁胺（Loperamide）只能在明确适合时作辅助。
不要这样做	不要用洛哌丁胺单药把血性/发热性腹泻“压住”；不要自行叠加多种抗生素。
何时复评/升级	高热持续、意识改变、少尿、严重腹痛/腹胀、黑便而非鲜血便，或 48 小时无改善 -> 升级。

贾第虫病可能 / Possible giardiasis

更像什么	贾第虫感染模式
怎么判断	污染水暴露后持续>1-2 周腹泻、腹胀、恶臭/油脂样便，通常不像急性痢疾那样高热血便。
先做什么	补液、营养支持；按预授权的原虫方案处理。
药物搭配	口服补液盐（ORS）+ 甲硝唑（Metronidazole，若医生预先选择该方案）。
不要这样做	阿苯达唑（Albendazole）不是贾第虫病的标准替代药；普通短暂水样腹泻不要随便用甲硝唑。
何时复评/升级	疗程后仍持续、明显体重下降/脱水，或出现血便高热 -> 重新诊断。

胃炎/反流/消化性溃疡样症状 / Acid-peptic symptoms

更像什么	GERD/胃炎/消化性溃疡样问题
怎么判断	烧心、反酸、上腹灼痛/不适；没有呕血、黑便、晕厥等出血信号。
先做什么	避免明显诱因，规律进食，必要时抑酸。
药物搭配	埃索美拉唑（Esomeprazole）；若已确认幽门螺杆菌，则仅按手册中预先选定的完整根除方案。
不要这样做	不要同时堆多个质子泵抑制剂；不要因为“胃痛”就启动阿莫西林（Amoxicillin）。
何时复评/升级	出现呕血/咖啡渣样物、柏油样黑便、晕厥、进行性贫血样乏力 -> 立即转入上消化道出血。

上消化道出血 / Upper GI bleeding	
更像什么	可能的胃/十二指肠等上消化道出血
怎么判断	吐鲜血/咖啡渣样物，或黑色柏油样便，伴头晕、冷汗、脉快/血压下降时尤其危险。
先做什么	停止活动、平卧保暖；反复呕吐时侧卧防误吸；尽一切办法寻找撤离/救援。
药物搭配	清醒且可安全吞咽时，埃索美拉唑（Esomeprazole）/质子泵抑制剂仅作辅助。
不要这样做	禁用布洛芬（Ibuprofen）/萘普生（Naproxen）；阿莫西林（Amoxicillin）不止血；不要把次水杨酸铋（Bismuth subsalicylate）当止血药。
何时复评/升级	持续呕血、反复黑便、意识改变、休克表现 = 家庭口服药无法解决的危重症。

0C-3. 泌尿、皮肤、咬伤与牙源感染

单纯性膀胱炎模式 / Lower UTI pattern	
更像什么	感染局限在膀胱的 UTI 更可能
怎么判断	尿痛 + 尿频 + 尿急，可能耻骨上不适；没有高热、寒战、腰/肋脊角痛或呕吐。
先做什么	饮水维持水化；确认不是阴道炎/性传播感染样表现。
药物搭配	按个人预授权：呋喃妥因（Nitrofurantoin）OR 复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）；不要两种一起吃。
不要这样做	呋喃妥因不能用于疑似肾盂肾炎；男性、妊娠、反复复杂 UTI 应使用单独预案。
何时复评/升级	24-48 小时应开始改善；出现高热/寒战/腰痛/呕吐或全身恶化 -> 视为可能已超出膀胱。

肾盂肾炎/复杂 UTI 可能 / Pyelonephritis-cUTI	
更像什么	感染可能已超出膀胱
怎么判断	尿路症状 + 发热/寒战 + 腰或肋脊角痛 +/- 恶心呕吐；可能快速进展为脓毒症。
先做什么	监测血压、心率、尿量和能否口服；尽可能获得尿培养/医疗支持。
药物搭配	只按医生为你们预先制定的“上尿路/复杂 UTI”口服方案；复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）等是否适用高度依赖既往培养/耐药情况。
不要这样做	不要用呋喃妥因（Nitrofurantoin）治疗肾盂肾炎；不要把普通膀胱炎方案机械升级为加倍剂量。
何时复评/升级	低血压、意识变差、持续呕吐、尿量明显减少、病情快速恶化 -> 脓毒症风险，口服家庭方案能力有限。

非化脓性蜂窝织炎 / Non-purulent cellulitis

更像什么	链球菌/MSSA 型皮肤软组织感染更可能
怎么判断	红、肿、热、痛向周围扩展，但没有明显中央脓液/波动感；可沿边缘画线观察扩展。
先做什么	抬高患肢、处理入口（裂口/脚癣等），观察边界和体温。
药物搭配	头孢氨苄（Cephalexin）OR 阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate），按 Rx 预案。
不要这样做	没有脓液时不要为了“保险”自动加多西环素（Doxycycline）或复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）。
何时复评/升级	24-48 小时炎症可能仍明显，但扩展应停止并逐渐改善；快速扩展、紫黑/坏死、水疱、剧痛远大于外观、低血压 -> 高危。

脓肿/化脓性皮肤感染 / Abscess-purulent SSTI

更像什么	脓肿或 MRSA 型感染可能
怎么判断	中央脓液、波动感、脓包；“有脓腔”比红肿本身更关键。
先做什么	核心是源控制/充分引流和清洁；不要用针乱扎深部/危险部位。
药物搭配	需要抗 MRSA 且已预授权时：多西环素（Doxycycline）OR 复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）。若同时必须覆盖链球菌，才考虑头孢氨苄（Cephalexin）+ 上述其中一种。
不要这样做	不要把两种 MRSA 药一起堆；抗生素不能替代明显脓腔的引流。
何时复评/升级	面部危险三角区、手部深部、会阴、快速扩展、全身症状或源控制失败 -> 升级。

猫/狗/人咬伤 / Bite wound

更像什么	多菌种咬伤污染/感染
怎么判断	深穿刺、手/关节附近、红肿热痛扩展或脓液；猫咬手部风险尤其高。
先做什么	立即大量冲洗；评估破伤风和狂犬病暴露风险；不要把深穿刺简单封死。
药物搭配	阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）+ 伤口冲洗/覆盖，按预设方案。
不要这样做	通常不要再额外叠加阿奇霉素（Azithromycin）或头孢氨苄（Cephalexin）；严重青霉素过敏需要单独替代方案。
何时复评/升级	手部功能下降、腱鞘/关节疼痛、快速扩展、发热或红线向近端延伸 -> 高风险。

牙源感染 / Dental infection

更像什么	牙源脓肿/扩散感染可能
怎么判断	牙痛伴局部/面部肿胀、脓液、发热或感染扩散；单纯冷热刺激痛不等于需要抗生素。
先做什么	尽可能进行牙科源控制/引流；保持口腔清洁和镇痛。
药物搭配	阿莫西林（Amoxicillin）OR 阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate，按预案）+ 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 无禁忌时布洛芬（Ibuprofen）。
不要这样做	不要只靠抗生素长期拖延脓肿；面颈部扩散感染可能威胁气道。
何时复评/升级	吞咽困难、流口水、舌下/下颌肿胀、张口困难、声音改变、呼吸困难 -> 紧急气道风险。

0C-4. 过敏与药物组合规则

单纯荨麻疹/轻度过敏 / Urticaria

更像什么	轻中度皮肤过敏
怎么判断	风团、瘙痒、局部肿胀，但没有喉舌肿、喘鸣、呼吸困难、晕厥/低血压。
先做什么	停止可能诱因，观察是否向呼吸/循环系统发展。
药物搭配	西替利嗪（Cetirizine）；局部皮炎/虫咬可加氢化可的松 1%（Hydrocortisone 1%）。
不要这样做	不要因为只有皮疹就随意用系统性泼尼松；一旦出现呼吸/循环受累，立即升级为过敏性休克。
何时复评/升级	症状快速扩展、多系统参与，尤其呼吸困难/喉舌肿/晕厥 -> 不再是“轻度过敏”。

过敏性休克 / Anaphylaxis

更像什么	严重全身过敏反应
怎么判断	突然喉舌肿、喘鸣/呼吸困难、晕厥/低血压，或皮肤症状同时伴呼吸/循环/明显胃肠多系统反应。
先做什么	立即使用肾上腺素自动注射器（EpiPen），大腿外侧；平卧保暖并启动一切可用救援。
药物搭配	肾上腺素自动注射器（EpiPen）是第一线；喘鸣可加沙丁胺醇（Salbutamol）；西替利嗪（Cetirizine）/泼尼松（Prednisone）只作辅助。
不要这样做	绝对不要为了等抗组胺药或泼尼松起效而延迟肾上腺素；不要让病人站起来走动。
何时复评/升级	5-15 分钟仍未改善/恶化且有第二支时按装置/预案再次使用；即使一度好转也要持续观察双相反应。

0C-5. 高价值药物搭配速查：什么时候“+”，什么时候“OR”

记忆规则：OR = 只选一个；“+” = 同时使用。联合抗生素只在覆盖目标不同且手册明确写“+”时使用。病情严重 ≠ 自动增加药物数量。

场景	合理搭配	为什么 / 关键限制
----	------	------------

流感	奥司他韦 (Oseltamivir) + 对乙酰氨基酚 (Acetaminophen) OR 布洛芬 (Ibuprofen) + 口服补液盐 (ORS)	抗病毒 + 退热镇痛 + 补液；呕吐影响饮水时可按预案加昂丹司琼 (Ondansetron)。
轻型社区获得性肺炎（无重要合并症）	阿莫西林 (Amoxicillin) OR 多西环素 (Doxycycline)	二选一，不是一起吃；仅在肺炎模式较明确且按预设用药单。
肺炎 + 重要合并症/预先授权的扩大覆盖	阿莫西林/克拉维酸 (Amoxicillin/Clavulanate) + 阿奇霉素 (Azithromycin) OR 多西环素 (Doxycycline)	只有医生预先授权的方案才使用“+”；不是三种一起吃。
呕吐 + 脱水	昂丹司琼 (Ondansetron) + 口服补液盐 (ORS)	先让液体留得住，再持续小口补液；休克/意识差时口服方案不足。
普通水样腹泻	口服补液盐 (ORS) + 洛哌丁胺 (Loperamide, 必要时)	核心是补液；血便或明显发热时不要把洛哌丁胺作为单药。
严重旅行者腹泻/痢疾预案	口服补液盐 (ORS) + 阿奇霉素 (Azithromycin) ± 洛哌丁胺 (Loperamide, 仅辅助)	血便/发热性腹泻时洛哌丁胺不能单独使用。

药物搭配速查（续）

场景	合理搭配	为什么 / 关键限制
非化脓性蜂窝织炎	头孢氨苄 (Cephalexin) OR 阿莫西林/克拉维酸 (Amoxicillin/Clavulanate)	通常先覆盖链球菌/MSSA；没有脓液时不要为了“保险”自动加 MRSA 药。
需要同时覆盖链球菌 + MRSA 的皮肤感染	头孢氨苄 (Cephalexin) + 多西环素 (Doxycycline) OR 复方磺胺甲噁唑 (TMP-SMX)	仅在化脓/穿透伤/既往 MRSA 等明确理由时；明显脓肿还需要源控制。
猫/狗/人咬伤感染	伤口大量冲洗 + 阿莫西林/克拉维酸 (Amoxicillin/Clavulanate)	通常不需要额外叠加阿奇霉素或头孢氨苄。
过敏性休克	肾上腺素自动注射器 (EpiPen) + 支持处理；喘鸣时可加沙丁胺醇 (Salbutamol)	西替利嗪 (Cetirizine) / 泼尼松 (Prednisone) 只能辅助，绝不能延迟肾上腺素。
胃酸/消化性溃疡症状	埃索美拉唑 (Esomeprazole)	不要同时堆多个质子泵抑制剂；呕血/黑便时这是辅助，不是止血。
幽门螺杆菌已确认	只按手册中医预先选定的一套完整根除方案	不要把阿莫西林 (Amoxicillin) 单独当作根除治疗，也不要临时拼药。

0C-6. 48-72 小时复评规则（给非医学背景使用者）

开始治疗后，每 4-8 小时记录：体温、心率、呼吸频率、血压/SpO2（如有）、尿量、能否饮水、疼痛/红肿范围。真正的改善是“趋势变好”：能喝、尿量恢复、呼吸轻松、发热和疼痛下降、红肿不再扩展。若 48-72 小时完全没有改善，先重新判断诊断和源控制，而不是自行再加第二种抗生素。任何时候出现 P0 危险信号都不等待 48 小时。
--

0C-7A. 惊恐发作（高度疑似） / Suspected Panic Attack

1. 更像什么：	突然强烈害怕或“要出事”的感觉，同时心跳快、胸闷、呼吸很快、头晕、手脚或嘴周发麻、发抖、出汗。常在压力/惊吓后出现，也可能无明显诱因。
2. 怎么判断：	更支持惊恐：人能完整说话；主要是“越紧张越喘、越喘越麻”的感觉；手脚/嘴周发麻；没有新出现的风团/全身瘙痒，没有嘴唇/舌头/脸肿，没有声音突然变哑/吞咽困难。真实喘鸣通常是“呼气时从胸口发出持续高调哨音”，哮喘还常有既往史、说话变困难。过敏性休克可以没有皮疹；若接触可疑食物/药物/虫蜇后出现喉紧、声音改变、胸口喘鸣、晕厥或反复呕吐，不按惊恐处理。持续压榨/紧缩样胸痛超过数分钟、向手臂/下颌/背部放射、冷汗/恶心/晕厥，也不按惊恐处理。
3. 先做什么：	让人坐下或半躺在安全处；一人安静陪同，减少围观。松开紧衣。呼吸节奏：鼻吸约 4 秒 -> 慢慢呼约 6 秒，重点“呼得更慢更长”，持续 5 分钟。再做 5-4-3-2-1 落地法：说出 5 个看到、4 个摸到、3 个听到、2 个闻到、1 个尝到/最确定的事实。

4. 药物搭配：	若符合“高度疑似惊恐”且没有上述危险信号：不使用肾上腺素自动注射器（EpiPen）、不使用沙丁胺醇（Salbutamol）、不使用抗生素。若在“惊恐还是过敏性休克”之间拿不准，但出现喉舌肿胀、声音改变、真实喘鸣、晕厥/脸色发灰等客观危险体征，应按过敏性休克处理。若本人已有医生开具并写明的焦虑急救药，只按个人既定预案。
5. 不要这样做：	不要套纸袋呼吸；不要让其连续做“又快又深”的大口深呼吸；不要用酒精/镇静药把人“压下去”；第一次出现明显胸痛/呼吸困难时不要直接贴上“焦虑”标签；若出现过敏或哮喘客观体征，不要为了节省药而拖延真正治疗。
6. 何时复评/升级：	5-10 分钟后重新看：呼吸是否变慢、麻木/胸闷是否减轻、能否正常说话和走动。15-20 分钟仍无明显改善、反而恶化，或任何时候出现嘴唇/舌头肿、声音变哑、真实喘鸣、晕厥/脸色发灰、嘴唇发蓝、持续/放射性胸痛、单侧无力/说话含糊 -> 立即改按躯体急症处理。

0C-7B. 低体温 / Hypothermia

1. 更像什么：	冬季断电、湿冷、长时间在车库/室外后出现发抖、手变笨、走路不稳、说话含糊、反应慢。更严重时：困倦/意识混乱、站不起来、反而不再发抖、呼吸明显变慢。
2. 怎么判断：	轻度：人清醒、能配合、持续发抖。中重度：越来越困、含糊、不能自己脱湿衣/走路、皮肤很苍白或发青、停止发抖。普通人不用追求“核心体温数字”，按这些肉眼体征分级。
3. 先做什么：	先阻断继续散热：移到避风干燥处，隔绝冰冷地面，脱掉湿透衣物、擦干、换干衣，盖住头颈和躯干。被动回温：干衣+睡袋/毯子+外层防风/急救毯。主动回温：把包布的温水袋/大号热包放在胸口、腋下或躯干旁，隔一层布并经常看皮肤是否发红/烫伤。完全清醒、能吞咽者可小口喝温热含糖饮料并吃高热量食物。中重度者轻柔、尽量平稳搬动。
4. 药物搭配：	没有“治疗低体温”的家庭药物。清醒者的温热含糖饮料/食物是补充能量，不是药。疼痛药不能解决失温。
5. 不要这样做：	严重失温者不要猛烈揉搓手脚；不要按摩冰冷四肢；不要把热包直接贴皮肤；不要用滚烫水、滚烫饮料、热水澡或直接烤火强行快速加热；不要喂酒；意识差/吞咽不安全的人不要灌任何液体。
6. 何时复评/升级：	每 10-15 分钟复评意识、说话、走路能力、发抖和呼吸。越来越困、停止发抖、不能站立、呼吸很慢/不规则、嘴唇发蓝、昏迷 -> 视为重度低体温；继续躯干回温、轻柔搬动、持续监测呼吸。若无正常呼吸，进入 CPR/AED 流程。

0C-8. 中度烧烫伤 / Moderate Burn

1. 更像什么：	红、痛并出现一个或多个水疱，皮肤常湿润、粉红/红色、触碰很痛。只有红和痛、没有水疱通常更浅。若皮肤发白/蜡样/焦黑、干硬，或中心反而没感觉，属于更深烧伤。
2. 怎么判断：	先判断面积和位置。小面积“起泡烧伤”如果只占不超过伤者 1 个手掌大小，且不在面部、手、脚、会阴、生殖器、大关节附近，也不是环绕整条手臂/腿/胸廓一圈，才更接近家庭可处理范围。
3. 先做什么：	立刻离开热源。尽快用干净、凉的流动水持续冷却 5-20 分钟；同时取下戒指、手表、皮带等会被肿胀卡住物品。冷却只针对烧伤处，别把整个人冻冷。冷却后，完整水疱轻盖干净不粘敷料；水疱已经破了，用可饮用水/生理盐水轻柔清洁，薄涂凡士林后盖不粘敷料。
4. 药物搭配：	疼痛：对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen，前提是没有胃出血、明显脱水、肾病等禁忌）。烧伤本身不因为“起泡”就自动需要口服抗生素。

5. 不要这样做：	不要挑破完整水泡；不要撕掉粘住皮肤的衣物；不要涂牙膏、酱油、食用油、酒精、碘酒或其他偏方；不要把冰块直接压在烧伤上；不要把烧伤紧紧缠死。
6. 何时复评/升级：	以下任何一条即超出普通家庭小烧伤范围：起泡/更深烧伤面积 > 伤者 1 个手掌；面部、颈部、手、脚、会阴/生殖器；绕肢体/胸廓一整圈的环形烧伤；跨大关节；电烧伤/化学烧伤；烟雾吸入、声音嘶哑、口鼻有黑灰；皮肤发白/焦黑/麻木；疼痛、红肿或渗液持续恶化。

0C-9. 浸渍足/战壕足 / Non-Freezing Cold Injury (Trench Foot)

- 更像什么：** 双脚在冷水、湿鞋或湿袜里待了数小时到数天；环境可以高于冰点。先是脚冰冷、苍白/发青/斑驳、麻木或刺痛，之后可能红肿、灼痛、起疱。
- 怎么判断：** 关键线索是“长时间湿 + 冷 + 没有真正冻硬”。如果脚趾/脚已经冻硬、蜡白，按冻伤处理；如果只是潮湿浸泡后麻木、肿痛，更像浸渍足。
- 先做什么：** 脱掉湿鞋湿袜 -> 轻轻擦干 -> 换干袜 -> 抬高双脚 -> 保持通风干燥 -> 尽量少走路。回温以干燥、缓慢、被动回温为主。
- 药物搭配：** 轻中度疼痛可用对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen，若无胃出血/脱水/肾病风险）。足粉只用于保持干爽，不是治疗药。
- 不要这样做：** 不要烤火、热风机直吹、热水长时间浸泡或快速猛加热；不要揉搓按摩麻木的脚；不要挑破水泡；不要忍着麻木继续长距离走。
- 何时复评/升级：** 每 2-4 小时看颜色、肿胀、感觉和水疱。出现皮肤发黑/灰紫、大片水疱、持续失去感觉、越来越肿痛、恶臭/流脓、发热或完全无法行走 -> 按严重冷伤/感染处理。

0C-10. 女性卫生、阴道炎与中毒性休克 / Vaginitis & TSS

- 更像什么：** 霉菌性阴道炎：明显瘙痒/灼热、外阴红、较厚白色分泌物，通常没有明显鱼腥味。细菌性阴道病（BV）：薄的灰白/乳白分泌物 + 明显鱼腥味，瘙痒通常不是最突出。
- 怎么判断：** 没有化验时只能做“更像哪一种”的判断，症状会重叠。下腹明显疼痛、发热、性交痛、异常出血、怀孕可能、溃疡/水疱或新性暴露 -> 不按普通阴道炎自行处理。
- 先做什么：** 保持外阴清洁干燥；只清洗外部，不做阴道灌洗；内裤/卫生巾勤换并保持干燥。灾害期优先外置卫生巾（Pads），不要自制内置棉条。
- 药物搭配：** 典型轻度霉菌症状：克霉唑（Clotrimazole）阴道制剂按包装完整疗程。预设处方可保留氟康唑（Fluconazole）150 mg 单次，但怀孕/可能怀孕时不要自行口服。典型有症状 BV：仅按医生预设方案使用甲硝唑（Metronidazole）；克霉唑/氟康唑不治疗 BV。
- 不要这样做：** 不要因为“有分泌物”就同时吃抗生素 + 抗真菌药；不要阴道冲洗；不要把香皂/漂白水/消毒液放进阴道；不要长时间留置棉条或自制内置吸收物。
- 何时复评/升级：** 治疗后 48-72 小时应至少不再恶化。突然高热 + 呕吐/腹泻 + 大片红疹 + 明显头晕、站不住/快晕倒，尤其正在使用棉条/阴道内用品 -> 立即取出，按中毒性休克综合征（TSS）/严重全身感染处理。

0C-11. 雪盲/光照性角膜炎 / Photokeratitis

- 更像什么：** 在雪地、强紫外线或电弧光暴露后数小时，双眼突然剧痛、流泪、畏光、像进了沙子，常两眼一起发作。
- 怎么判断：** 有明确强光/雪地暴露 + 延迟数小时出现双眼疼痛更支持雪盲。单眼明显疼、眼里有异物、化学品入眼、眼球被击中或视力明显下降 -> 不按雪盲处理。

- 3. 先做什么：** 停止紫外线暴露 -> 到暗处休息/戴 UV400 太阳镜 -> 冷敷闭眼 -> 无防腐剂人工泪液。多数表面损伤会在 24-72 小时内明显改善。
- 4. 药物搭配：** 人工泪液 + 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen，若无禁忌）。不把抗生素眼膏当作所有雪盲的必需药。
- 5. 不要这样做：** 不要揉眼；不要继续暴露在雪地强光；不要自行滴局部麻醉眼药；不要长期紧密包眼；戴隐形眼镜者立即停戴。
- 6. 何时复评/升级：** 24 小时应开始改善。48-72 小时仍明显疼痛、单眼越来越严重、视力下降、角膜出现白点/浑浊、脓性分泌物 -> 不是普通雪盲，按严重眼病处理。

0C-12. 结膜炎/红眼病（非创伤性） / Conjunctivitis

- 1. 更像什么：** 病毒性：红、流泪、异物感，常一只眼开始后传到另一只，家里其他人也可能出现。细菌性：黏稠黄绿/脓性分泌物较多，醒来眼皮被粘住。过敏性：双眼很痒、流泪，常伴鼻痒/打喷嚏。
- 2. 怎么判断：** 普通结膜炎通常是表面红、痒/涩、分泌物，但视力擦掉分泌物后基本正常。明显眼痛、强烈畏光、视力下降、角膜白点/浑浊、瞳孔异常 -> 不像普通红眼病。
- 3. 先做什么：** 洗手至少 20 秒；不要眼；毛巾、枕巾、眼水分；用干布/棉片从内向外清理分泌物，用后丢弃；冷敷 + 人工液；停戴隐形眼镜。
- 4. 药物搭配：** 病毒性：人工泪液 + 冷敷，不用抗生素。明显脓性、预设为细菌性时，可按医生方案使用红霉素眼膏（Erythromycin ophthalmic ointment）。过敏性以避免过敏原和抗过敏方案为主。
- 5. 不要这样做：** 不要共用毛巾/枕头/眼药水；不要一红就用抗生素；不要用剩余的激素眼药水；不要把同一瓶眼药水瓶口碰到眼睛后再给另一人用。
- 6. 何时复评/升级：** 每天复评。明显眼痛、畏光、视力下降、红得越来越厉害，或细菌性方案使用 24 小时仍明显恶化 -> 按角膜炎/严重眼病处理。隐形眼镜使用者出现红眼 + 疼痛属于高风险。

2. 发热、咳嗽、鼻塞、咽痛：怎么区分 / Respiratory & Throat Decision Guide

普通病毒性上呼吸道感染 Viral URI	
如何判断	流鼻涕、鼻塞、咳嗽、声音沙哑、咽痛；通常逐渐改善
家庭/预设用药单 处理	对乙酰氨基酚（Acetaminophen）OR 布洛芬（Ibuprofen）+ 补液 + 鼻腔盐水；有过敏表现可 西替利嗪（Cetirizine）
不要误判	不要因为黄痰/绿鼻涕就自动使用抗生素

流感 A/B Influenza	
如何判断	突然发病；发热/寒战、明显肌痛、头痛、乏力 + 呼吸道症状；流感季/聚集病例更支持
家庭/预设用药单 处理	奥司他韦（Oseltamivir）+ 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）+ 口服补液盐（ORS）；越早开始通常越有价值
不要误判	奥司他韦（Oseltamivir）不治疗普通感冒、RSV 或细菌性肺炎

链球菌性咽炎 GAS strep throat	
如何判断	突然明显咽痛、发热、扁桃体渗出、颈前淋巴结痛；通常缺乏咳嗽/流鼻涕
家庭/预设用药单 处理	最好 RADT/咽培养确认；阳性时 阿莫西林（Amoxicillin）（或 青霉素（Penicillin））+ 镇痛退热
不要误判	有明显咳嗽、流涕、声音嘶哑、口腔溃疡更偏病毒，不用抗生素

急性支气管炎 Acute bronchitis	
如何判断	咳嗽为主，可有痰；没有肺炎红旗；常由病毒引起
家庭/预设用药单 处理	补液 + 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）/布洛芬（Ibuprofen）；有明确喘鸣且本人有预案可 沙丁胺醇（Salbutamol）
不要误判	通常不使用抗生素；痰颜色不能可靠区分细菌/病毒

细菌性鼻窦炎 Bacterial sinusitis	
如何判断	三种模式之一：>10 天不改善；≥39°C 高热伴脓涕/面痛持续 3-4 天；或先好转后再次恶化
家庭/预设用药单 处理	阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）+ 鼻腔盐水冲洗 + 镇痛；过敏性鼻炎可加 氟替卡松鼻喷剂（Fluticasone nasal）
不要误判	短期普通感冒前几天不要上抗生素

社区获得性肺炎 CAP	
如何判断	发热/咳嗽 + 呼吸急促、胸膜性胸痛、SpO2 下降、明显乏力；肺部局灶性异常更支持
家庭/预设用药单 处理	健康低风险成人：阿莫西林（Amoxicillin）OR 多西环素（Doxycycline）；有重要基础病时常用 阿莫西林/克拉维酸（Amox/Clav）+ 阿奇霉素（Azithromycin）OR 多西环素（Doxycycline）（需 预设用药单）
不要误判	呼吸窘迫、低氧、低血压、意识改变 = 超出家庭口服治疗能力

咽痛最容易误用抗生素。CDC：出现清楚的病毒症状时不需要做链球菌检测；确诊 GAS 才使用抗生素，首选 青霉素（Penicillin）/阿莫西林（Amoxicillin）。

3. 慢性咽喉炎 / Persistent or Chronic Sore Throat - 专门章节

“慢性咽炎”更像一个症状标签，不是一个单一病因。持续 >10 天或反复数周的咽喉不适，常见原因包括：鼻后滴流/过敏、LPR/GERD 反流、干燥/张口呼吸、烟雾或化学刺激、声音过度使用、慢性扁桃体问题；持续感染只是其中一部分。

过敏/鼻后滴流 Allergy / post-nasal drip	
怎么识别	鼻痒、喷嚏、鼻塞、清鼻涕；咽后黏液、反复清嗓；季节性或接触尘螨/宠物后加重
治疗/康复	鼻腔盐水冲洗 + 氟替卡松鼻喷剂（Fluticasone nasal）（按标签/医生指导）+ 西替利嗪（Cetirizine）；补水
重点	持续控制鼻炎比反复吃“消炎药”更重要

咽喉反流 LPR / GERD	
怎么识别	反复清嗓、异物感、声音嘶哑、晨起咽痛、酸/苦味；饭后或躺下加重；可没有典型烧心
治疗/康复	生活方式 + 海藻酸钠（Sodium alginate）/海藻酸盐制剂（Gaviscon）；明显反流可按预案使用 埃索美拉唑（Esomeprazole）或 法莫替丁（Famotidine）
重点	质子泵抑制剂（PPI）对所有“慢性咽炎”都不是万能药；若无反流线索不要长期自行使用

干燥/张口呼吸 Dry air / mouth breathing	
怎么识别	晨起最干最痛、口干、打鼾/鼻塞、冬季暖气环境明显
治疗/康复	卧室加湿 + 鼻腔盐水 + 充分饮水 + 处理鼻塞；避免过热空气
重点	长期湿度过高可促霉菌，目标舒适而非“越湿越好”

声音过度/刺激物 Voice strain / irritants	
怎么识别	说话多、喊叫后加重；烟、vape、粉尘、强清洁剂后刺痛
治疗/康复	声带休息、补水、避免刺激物；需要时口罩/通风
重点	不要靠含麻醉成分含片长期掩盖持续症状

反复扁桃体/细菌感染 Recurrent tonsillitis	
怎么识别	每次急性发作都有发热、明显扁桃体肿大/脓点、颈部压痛；发作间歇可能缓解
治疗/康复	急性发作按“急性咽炎”规则评估；最好检测 GAS；反复发作考虑 ENT
重点	不要因“慢性咽炎”三个字长期吃 阿莫西林（Amoxicillin）

日常康复计划 / Recovery & Prevention

- 每天足量饮水；温水/蜂蜜（成人）可缓解刺激。温盐水漱口可作为舒适措施。
- 卧室保持舒适湿度，冬季暖气环境尤其注意；同时防止霉菌。
- 减少反复“清嗓”：可改成小口喝水、轻吞咽或轻咳，减少机械摩擦。
- 避免烟草、vape、二手烟、香薰/清洁剂刺激、过热饮品和长期大声说话。

- 若偏 LPR：睡前 2-3 小时不进食；少量多餐；饭后不立即躺下/剧烈运动；减少酒精、咖啡因、碳酸、油炸/辛辣及个人触发食物；必要时抬高床头。
- 若偏鼻炎/鼻后滴流：规律鼻腔盐水，控制过敏源；鼻喷激素需要“连续规律使用”而不是只在很难受时喷一次。

慢性咽痛必须重新评估的信号 / Red flags

持续或进行性吞咽困难、单侧持续疼痛、咽痛放射到耳、颈部肿块、持续不明原因声音嘶哑、咳/吐血、原因不明体重下降、呼吸困难，或口腔溃疡/肿块超过 3 周 -> 不应继续按“慢性咽炎”自行处理，应寻找 ENT/医疗评估。

4. 胃肠道：呕吐、腹泻、胃痛、黑便 / Gastrointestinal Decision Guide

普通急性胃肠炎 Acute gastroenteritis	
判断线索	水样腹泻/恶心呕吐，无血便、无明显高热、无局灶性剧痛
药物/处理	口服补液盐（ORS）为核心；呕吐妨碍补液时 昂丹司琼（Ondansetron）；无血无高热时可短期 洛哌丁胺（Loperamide）
关键限制	多数不需要抗生素

严重旅行者腹泻 Severe travelers diarrhea	
判断线索	腹泻严重影响行动/无法完成日常活动；或明显感染表现
药物/处理	口服补液盐（ORS）+ 阿奇霉素（Azithromycin）（需预授权）；无血无高热时可加 洛哌丁胺（Loperamide）
关键限制	重点仍是补液；抗生素不是“止泻药”

痢疾/发热性腹泻 Dysentery / febrile diarrhea	
判断线索	血便或腹泻伴明显发热
药物/处理	口服补液盐（ORS）+ 阿奇霉素（Azithromycin）（预设用药单）
关键限制	不要单独用 洛哌丁胺（Loperamide）把血性/发热性腹泻“压住”

Giardia 贾第虫	
判断线索	持续腹泻 >1 周、腹胀、恶臭/油脂样便，污染水暴露史
药物/处理	口服补液盐（ORS）+ 甲硝唑（Metronidazole）（若医生预先选定该方案）
关键限制	普通短期腹泻不要自行用 甲硝唑（Metronidazole）

常见肠道蠕虫 Intestinal helminths	
判断线索	蛲虫：夜间肛周瘙痒最典型；蛔虫/钩虫/鞭虫症状可不典型，可能有腹痛、贫血或粪便见虫体/虫卵
药物/处理	阿苯达唑（Albendazole）仅在症候群匹配或已有明确诊断/预案时使用
关键限制	阿苯达唑不治疗 Giardia、细菌性腹泻或病毒性胃肠炎；复杂寄生虫病不要靠家庭药箱处理

GERD/胃炎	
判断线索	烧心、反酸、上腹灼痛，与饮食/躺下相关，无出血警讯
药物/处理	埃索美拉唑（Esomeprazole）OR 法莫替丁（Famotidine）；反流屏障可 海藻酸钠（Sodium alginate）/海藻酸盐制剂（Gaviscon）
关键限制	持续吞咽困难、贫血/体重下降等需进一步评估

消化性溃疡 Peptic ulcer	
判断线索	持续上腹痛、既往溃疡/H. pylori/非甾体抗炎药（NSAID）风险
药物/处理	质子泵抑制剂（PPI）；若 H. pylori 确诊再进入完整根除方案
关键限制	不要仅凭胃痛自行开抗生素

H. pylori 已证实	
判断线索	呼气/粪抗原/胃镜证实
药物/处理	方案 A: 质子泵抑制剂（PPI）+ 铋剂（Bismuth）+ 四环素（Tetracycline）+ 甲硝唑（Metronidazole）；方案 B: 伏诺拉生（Vonoprazan）+ 阿莫西林（Amoxicillin）（按医生方案）
关键限制	不是急性胃出血止血方案；治疗后要做 test of cure

上消化道出血 Upper GI bleed	
判断线索	吐鲜血/咖啡渣样物、柏油样黑便、头晕冷汗/脉快
药物/处理	质子泵抑制剂（PPI）只能辅助 + 保暖平卧 + 监测 + 尽力撤离
关键限制	不要自行用 非甾体抗炎药（NSAIDs）；不能靠 阿莫西林（Amoxicillin）/伏诺拉生（Vonoprazan）组合“止血”

阿苯达唑片：常见肠道蠕虫速查 / 阿苯达唑（Albendazole）

- 蛲虫（Enterobius）：夜间肛周明显瘙痒、睡眠不安；可用透明胶带试验。CDC 成人方案：阿苯达唑 400 mg 口服一次，2 周后再重复一次；第二次用于杀灭第一剂后由虫卵孵化出的虫体。
- 蛔虫或钩虫：CDC 成人参考为阿苯达唑 400 mg 口服一次；鞭虫：400 mg 每日一次，共 3 天。
- 家庭成员出现蛲虫时，卫生措施非常重要：勤洗手、剪短指甲、晨起洗澡、更换内衣和床品；重复感染很常见。
- 阿苯达唑不是“腹泻万能药”。污染水后持续油脂样恶臭腹泻更像 Giardia，处理逻辑不同。妊娠/可能妊娠、明显肝病或需要多日/反复疗程时，应按预先医疗方案使用。
- 不要把人的阿苯达唑直接给猫使用；宠物驱虫由兽医按体重和寄生虫种类选择。

口服补液盐（ORS）配制原则：严格按包装要求的水量配，不要随意加浓。持续呕吐时可以每次只喝几口，频繁补充；重度脱水/休克时口服方案不足。

5. 泌尿、牙源、皮肤与伤口 / UTI, Dental, Skin & Wounds

单纯性膀胱炎 Uncomplicated cystitis	
怎么识别	尿频 + 尿急 + 尿痛；无高热、无腰痛/寒战
处理/药物	呋喃妥因（Nitrofurantoin）OR 复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）（只按个人 预设用药单）+ 补水
重点	发热/腰痛/呕吐 -> 考虑肾盂肾炎；呋喃妥因（Nitrofurantoin）不适合肾盂肾炎

肾盂肾炎 Pyelonephritis	
怎么识别	UTI 症状 + 高热/寒战 + 单侧腰/肋脊角痛 ± 恶心呕吐
处理/药物	优先撤离；只能使用医生事先为个人设计的专门方案
重点	可能快速进展为败血症，不应按普通膀胱炎处理

牙源感染 Dental infection	
怎么识别	牙痛 + 牙龈/面部肿胀、脓液、发热或感染扩散
处理/药物	源控制/引流最重要；阿莫西林（Amoxicillin）或 阿莫西林/克拉维酸（Amox/Clav）（按预案）+ 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）/布洛芬（Ibuprofen）
重点	单纯牙髓痛没有扩散感染时，抗生素常帮不上忙

非化脓性蜂窝织炎 Cellulitis	
怎么识别	红、热、肿、痛向外扩展，但没有明显脓腔
处理/药物	头孢氨苄（Cephalexin）OR 阿莫西林/克拉维酸（Amox/Clav）；抬高患肢，标记红肿边缘观察趋势
重点	出现坏死/水疱/剧痛或快速进展 -> 危险

脓肿/MRSA 风险 Abscess / purulent SSTI	
怎么识别	局部有脓、波动感、脓头；可伴周围红肿
处理/药物	充分引流/源控制 + 多西环素（Doxycycline）OR 复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）（有系统症状/高风险时按预案）
重点	有脓腔时只吃抗生素往往不够；深部/面部危险区不要随意切开

猫/狗/人咬伤 Bite wound	
怎么识别	深穿刺，尤其手部/关节附近；随后红肿热痛
处理/药物	大量冲洗 + 阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）；检查破伤风状态
重点	猫咬形成深穿刺感染风险高；靠外用不够

脚癣/股癣/体癣 Tinea	
怎么识别	环形鳞屑、边缘活跃、趾缝脱皮/瘙痒
处理/药物	克霉唑外用制剂（Clotrimazole topical）+ 保持干燥
重点	不要口服抗生素

小切口/擦伤 Minor wound	
怎么识别	表浅、无大量出血、无深部结构损伤
处理/药物	大量清洁水/生理盐水冲洗 + 凡士林（Petrolatum）+ 无粘敷料
重点	不要把高浓度消毒剂反复灌进深部组织

轻度烧伤 / Minor thermal burn

- 移离热源；尽快用凉的流动水持续冷却（不要用冰直接贴）；移除未粘住的饰物/衣物；覆盖干净不粘敷料；疼痛可 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）或在无肾病/GI 出血/脱水时 布洛芬（Ibuprofen）。
- 大面积、环形、面颈/手/会阴、电烧伤、化学烧伤或吸入伤不属于家庭小伤处理范围。

6. 过敏、哮喘、疼痛与常见对症处理 / Allergy, Asthma & Symptom Control

普通荨麻疹/虫咬 Urticaria / bites	
判断线索	皮肤风团、瘙痒，无呼吸/循环症状
药物搭配	西替利嗪（Cetirizine）；局部炎症可短期 氢化可的松（Hydrocortisone）1%
注意	出现喉肿/呼吸困难/晕厥立即按 anaphylaxis

过敏性休克 Anaphylaxis	
判断线索	快速出现呼吸/循环危险或多系统过敏
药物搭配	肾上腺素自动注射器（EpiPen）为一线：立即使用 + 平卧保暖 + 启动撤离/求救；喘鸣可加沙丁胺醇，西替利嗪仅辅助皮肤症状
注意	没有口服替代药；不要误以为西替利嗪或泼尼松能逆转休克

哮喘/支气管痉挛 Asthma exacerbation	
判断线索	喘鸣、胸闷、呼气困难，通常有既往史或明确诱因
药物搭配	沙丁胺醇（Salbutamol） + spacer；中重度按个人计划可 泼尼松（Prednisone）
注意	若由 anaphylaxis 引起，肾上腺素（epinephrine）才是第一线

发热/一般疼痛 Fever & pain	
判断线索	感染、头痛、牙痛、肌肉痛
药物搭配	对乙酰氨基酚（Acetaminophen）；炎症性疼痛且无禁忌可 布洛芬（Ibuprofen）
注意	避免复方感冒药重复计算 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）

扭伤/软组织损伤 Sprain/strain	
判断线索	扭伤后局部肿痛，但无明显畸形/神经血管问题
药物搭配	保护/固定、抬高、冷敷早期可缓解；对乙酰氨基酚（Acetaminophen）或 布洛芬（Ibuprofen）
注意	明显畸形、开放伤、远端麻木/苍白需按骨折/血管损伤处理

鼻炎/鼻后滴流 Rhinitis/PND	
判断线索	鼻塞、喷嚏、清涕、鼻痒、咽后黏液
药物搭配	Saline irrigation + 氟替卡松鼻喷剂（Fluticasone nasal） + 西替利嗪（Cetirizine）（过敏性）
注意	规律鼻喷通常比偶尔喷一次更有效

联合/错峰镇痛（成人）：先用单药；若骨折、较大烧伤等疼痛仍明显，且没有胃肠出血、明显脱水、肾病、部分抗凝治疗等禁忌，可在严格遵守各自最低给药间隔与 24 小时最大量的前提下，将对乙酰氨基酚（Acetaminophen）与布洛芬（Ibuprofen）合用或错开。每次必须记录药名、剂量和时间。不要机械执行“每 3 小时交替”，也不要凭记忆补药。
非甾体抗炎药（NSAIDs）（如 布洛芬（Ibuprofen）/萘普生（Naproxen））在胃肠道出血、明显脱水、严重肾病或某些抗凝治疗下风险明显增加。

6A. 普通人急救核心技能 / Layperson Emergency Skills

这一部分不是让普通人“学会当医生”，而是让家里任何成年人在高压下知道先做什么。总原则：先处理会在几分钟内致命的问题，再处理疼痛、伤口和药物。

6A-0. 先认识你实际买的 IFAK / Your Actual Kit

这套包的定位：它首先是一套“前 10 分钟创伤急救包”，最强的是控制大出血、临时固定、保暖和处理部分胸壁开放伤。它不是完整的长期伤口护理包，也不等于医院。普通人只使用下表标为“可用”的器材。

A. 套装清单：拿到手先按编号整理

编号	套装物品	普通人主要用途	关键限制/提醒
[1]	绞棒式止血带 x1	四肢危及生命的大出血；旋紧到出血停止。	只用于手臂/腿；不要绑颈部、胸腹；真正使用后不要自行定时松开。
[2]	16 cm 创伤剪 x1	快速剪开裤腿、袖子、上衣，暴露真正伤口。	贴近皮肤剪衣物时把钝头朝向皮肤，避免盲剪。
[3]	14G 胸腔针 x1	留给受过训练的医生/急救人员。	普通人不做针减压；不要把文字说明当作侵入性操作训练。
[4]	布基胶带 x1	固定纱布、夹板、三角巾；临时加固。	不要环绕肢体缠得过紧导致远端发白/发紫/麻木。
[5]	三角巾 x1	悬吊前臂、辅助固定肩/上肢；与夹板配合。	不是止血带；不要勒住颈部。
[6]	18 英寸夹板（约 110x460 mm）x1	疑似骨折/严重扭伤时临时固定。	普通人不强行复位；固定前后都检查手指/脚趾血流和感觉。
[7]	急救毯 1.6x2.1 m x1	大出血、休克、低温环境中保暖并隔绝地面。	不要覆盖口鼻；靠近火源时注意熔化/燃烧风险。

到货后 30 秒验收（很重要）
图片只能确认卖家标称配置，不能证明止血带或胸封的实际性能。收到后先核对数量、包装密封和有效期；检查[1]止血带带体、绞棒、固定扣是否破损；检查[9]胸封胶面包装是否完整并确认是否明确写有 VENTED/排气型。图中[10]/[11]按普通压缩纱布处理；除非实物包装明确标注含止血剂/HEMOSTATIC，否则不要把它当“止血纱布”。任何破损、污染、过期或粘性明显失效的部件不要作为主用器材。



套装卖家示意图（仅用于认物；器材性能与包装状态以收到的实物为准）

B. 套装清单（续）

编号	套装物品	普通人主要用途	关键限制/提醒
[8]	一次性丁腈手套 x1 双	接触血液/体液前先戴，保护施救者。	一双太少时优先给最血腥的操作；破损后更换。

编号	套装物品	普通人主要用途	关键限制/提醒
[9]	胸腔密封贴 x1	仅用于明确胸壁开放/穿透伤；若包装明确写 VENTED，按说明使用。	若类型不明/非排气型，不要默认“完全密封”更安全；贴后呼吸变差要松开/移除。
[10]	压缩曲线/折叠纱布 x1	直接压迫；深部伤口填塞。	要把纱布真正填入胸腔并持续强压，不是只盖在洞口。
[11]	压缩纱布 x1	直接压迫、填塞、覆盖伤口。	若第一包被鲜血完全浸透，不要把底层反复揭开；在上面继续加压。
[12]	4 英寸急救创伤绷带 x1	止血已控制后维持持续压力；也可固定敷料。	不能代替深伤口填塞或正确止血带。
[13]	TCCC 伤员卡 x1	记录受伤时间、止血带时间、意识/呼吸变化、用药。	套装图中没有明确看到记号笔；建议把永久记号笔和卡放一起。
[14]	急救手册 x1	作为备用说明。	现场优先使用本手册的普通人流程；不要在大出血时先翻书。
【红色警告 - [3] 14G 胸腔针】保留在包里可以，但请单独封袋并写“专业人员使用”。普通人不要尝试胸腔针刺减压、胸腔穿刺或气管切开。开放性胸部伤的普通人任务是：呼救/撤离、保持呼吸、按本手册处理胸壁伤口并持续复评。			

C. 不记器材名字也能用：看到什么 -> 拿什么

看到什么	立刻怎么做	拿套装里的什么	别做什么
手臂/腿大量喷射或持续涌血	先强压；若危及生命且压不住，用止血带，旋紧到出血停止并记时间。	[8]手套 + [2]剪刀 + [1]止血带 + [13]伤员卡	不要因疼痛而松止血带。
腹股沟/腋窝等深洞状大出血	把纱布一层层填入胸腔，双手持续强压；控制后用压力绷带固定。	[10]/[11]纱布 + [12]创伤绷带	不要把止血带套在躯干/颈部。
普通切口/撕裂伤出血	直接压迫直到止血；之后用可获得的清洁水充分冲洗，再覆盖。	[11]纱布 + [12]创伤绷带；[4]胶带	不要不停揭开检查血有没有停。
手脚明显畸形/疑似骨折	保持发现时姿势，用夹板固定伤处上下；前后检查远端颜色、温度、感觉。	[6]夹板 + [5]三角巾 + [4]胶带	不要强行掰直/复位。
胸口有穿透洞、吸气漏气声	立即按危重处理。若胸封明确为排气型，可按说明使用；否则可保持开放或干净非密闭覆盖。	[9]胸封（仅在适合时） + [8]手套	贴上后若更喘，松开/移除；[3]针不要用。
伤员脸白、冷汗、发抖、意识变差	先确保大出血已控制，平卧/安全体位，隔绝地面并保暖，持续记录。	[7]急救毯 + [13]伤员卡	不要让严重伤员自己走动。

D. 买回来第一天这样整理（普通人最重要）

- 把 [1] 止血带放在最外层、单手能摸到的位置；不要压在包底。
- 把 [10][11][12] 放成一个“出血模块”；[6][5][4] 放成一个“固定模块”；[7] 急救毯放在容易抽出的地方。
- 把 [3] 14G 胸腔针单独封袋，并贴“专业人员使用 - 普通人不要操作”。
- 检查 [9] 胸封包装：如果明确写 VENTED / 排气型，在本手册封面内页记录；如果不明确，按“未知类型”处理。
- 在 [13] TCCC 卡旁边增加一支永久记号笔；没有笔时，止血带时间很容易忘记。
- 灾前用训练用品/模型练习止血带和伤口填塞；不要为了练习把真实止血带长时间完全绞紧在真人肢体上。
- 这套包没有专门的长期伤口护理物资：普通伤口后续仍需要可饮用水/生理盐水、无粘敷料等；没有生理盐水时，干净可饮用流动水可用于冲洗普通伤口。建议另配：Steri-Strips 免缝胶带、复方安息香酊（只涂完整皮肤）、Dentemp/氧化锌类临时补牙材料。

6A-1. 60 秒总流程：安全 -> 反应/呼吸 -> 大出血 -> 全身快速看 -> 保暖记录

- 1. 先看环境。火、倒塌、电线、燃气、交通、暴力、化学品仍在威胁时，不要贸然进入。先保护自己。
- 2. 看人醒不醒、呼吸是否正常。大声呼叫、轻拍肩膀。无反应且没有正常呼吸/只有濒死样喘息 -> 立即呼救、开始胸外按压并尽快使用 AED。
- 3. 找“正在大量流血”的地方。血喷射/持续涌出、很快浸透衣物/敷料、地面形成血泊 -> 先止血。
- 4. 再快速看头、颈、胸、腹、骨盆、四肢。重点找明显畸形、开放伤口、呼吸困难、腹部持续痛、手脚发白/发紫/冰冷。

- 5. 处理后保暖并记录。记时间、意识、呼吸、脉搏、血压/血氧（有设备时）、出血量趋势、用过什么药/止血带何时上。

无反应 + 没有正常呼吸：成人心搏骤停快速卡

怎么认：叫不醒，胸口没有正常起伏；或只有不规律的“喘一下、停一下”的濒死样喘息。

立刻做：先呼救/拨打当地急救电话；把人仰卧在坚硬平面。双手叠放在胸部正中，连续用力按压。普通成人目标约 100-120 次/分、深度约 5-6 cm，每次让胸廓完全回弹。没有受过人工呼吸训练时，持续胸外按压也比等待更好；有 AED 就按语音提示使用。

用什么：AED；一次性手套/面罩（有条件）；计时工具。

不要做：不要为了反复“摸脉搏”而长时间停止按压；不要因为担心压断肋骨而完全不按。

升级/危险信号：只要没有恢复正常呼吸/明显生命迹象，就持续到救援接手、现场变得不安全或施救者无法继续。

成人噎住 / 严重气道异物梗阻（Choking）

怎么认：还能咳嗽和说话 = 气道仍有空气；完全说不出话、无声咳嗽、无法吸气、抓住喉咙、迅速发紫 = 严重梗阻。

立刻做：还能有效咳嗽时鼓励用力咳。严重梗阻且仍清醒：按接受过的急救培训实施背部拍击/腹部冲击；如果失去反应，立即按心搏骤停流程开始 CPR，并在每次开放气道时只取出“清楚看得见”的异物。

用什么：AED（若失去反应）；急救呼救。

不要做：不要盲目把手指伸进嘴里“掏”；不要给完全梗阻的人灌水。

升级/危险信号：无法发声/呼吸、意识变差或失去反应。

癫痫发作 / Seizure

怎么认：突然倒地、全身抽动、短暂意识丧失；发作后常有几分钟到更久的迷糊/疲倦。

立刻做：移开周围硬物，保护头部，记录开始时间。抽搐结束后检查呼吸；能正常呼吸但仍迷糊时让其侧卧并持续观察。

用什么：柔软垫物、计时工具。

不要做：不要压住四肢；不要把勺子、手指或任何物品塞进嘴里；不要在意识未恢复时喂水/药。

升级/危险信号：第一次发作；持续>5 分钟；连续多次且中间未恢复；受伤、怀孕、呼吸困难；结束后 5-10 分钟仍未逐渐恢复。

6B. 外伤处理 / Trauma First Aid - 普通人卡片

外伤的药物通常排在后面。真正决定结果的往往是：止血、冲洗、固定、保持呼吸、避免失温和持续复评。每张卡都按“怎么认 -> 立刻做 -> 用什么 -> 不要做 -> 何时升级”排列。

【按这套包处理外伤的原则】大出血：先[10]/[11]强压/填塞，四肢危及生命时用[1]止血带；骨折：用[6]+[5]+[4]固定；胸壁开放伤：仅在适合时用[9]，并持续观察呼吸；[3] 14G 胸腔针普通人不使用。

6B-1. 大出血、深伤口、断肢与异物

危及生命的大出血 / Life-threatening bleeding

怎么认：血喷射或持续大量涌出；几分钟内浸透敷料/衣物；地面快速积血；截肢；伤员开始苍白、冷汗、迷糊。

立刻做：第一步直接用双手/纱布持续强压。深而大的伤口用本套装压缩纱布填满伤腔；若以后另配止血纱布，也按同样原则填塞，再持续压迫。四肢出血若直接压迫/填塞仍控制不住，使用正规止血带。

用什么：本套装：[8]丁腈手套、[10]/[11]压缩纱布、[12]急救创伤绷带、[1]绞棒式止血带。

不要做：不要每隔几十秒掀开看；不要把止血带绑在颈部/躯干；不要用“止血药”替代机械止血。

升级/危险信号：任何持续大出血、意识变差、四肢冰冷、呼吸越来越快，都视为休克并优先撤离。

止血带 / Tourniquet: 普通人最简步骤

怎么认: 只用于手臂或腿的危及生命大出血, 尤其直接压迫/填塞无法控制时。

立刻做: 暴露伤口后, 把正规止血带放在伤口上方约 5-7 cm (2-3 英寸), 不要压在肘/膝关节上; 拉紧后旋转绞棒直到出血停止, 固定绞棒并记录时间。看不到伤口或现场极危险时, 可按受训方法“高位紧扎”。

用什么: 本套装: [1]绞棒式止血带 + [13]TCCC 伤员卡; 另建议放一支永久记号笔。

不要做: 一旦真正用于止住危及生命出血, 不要自己定时松开; 不要用细绳/电线当作常规替代品。

升级/危险信号: 止血带上好仍出血 -> 检查是否足够紧/位置是否正确; 若按产品训练仍止不住, 可在其上方再加第二条并尽快撤离。

伤口里插着东西 / Impaled object

怎么认: 刀片、木条、玻璃、金属等仍插在身体里。

立刻做: 通常不要拔。用厚纱布/卷起的布在异物两侧垫高并固定, 压迫伤口边缘止血, 避免异物继续晃动。

用什么: 本套装: [10]/[11]纱布 + [4]布基胶带; 必要时用[12]创伤绷带辅助固定。

不要做: 不要直接压在异物顶端; 不要随意拔出后再处理。

升级/危险信号: 胸、腹、颈、眼部异物; 大量出血; 呼吸困难; 神经功能异常。

完全断肢/断指 / Amputation

怎么认: 肢体或手指/脚趾完全离断。

立刻做: 先处理伤员的大出血。离断部分用干净/无菌纱布包裹, 可用生理盐水轻微湿润; 放进密封塑料袋, 再把这个袋子放进另一个有冰水混合物的容器里保持低温。和伤员一起带走。

用什么: 纱布、生理盐水、密封袋、第二层容器、冰水。

不要做: 不要让组织直接接触冰块、干冰或直接泡在水里; 不要为了找断肢而耽误给伤员止血。

升级/危险信号: 所有完全/部分截肢都需要尽快得到高级医疗支持。

6B-2. 普通伤口、穿刺、咬伤与破伤风**擦伤/小切口 / Abrasion & minor cut**

怎么认: 皮肤表浅破损, 出血能靠短时间直接压迫控制, 伤口没有明显张口很深。

立刻做: 先洗手/戴手套; 用大量干净流动水或 0.9%生理盐水冲洗, 把可见砂石污物冲掉; 止血后薄涂凡士林并盖不粘敷料, 按渗液情况换药。

用什么: 清洁水/0.9%生理盐水、纱布、不粘敷料、凡士林、胶带。

不要做: 不要在干净伤口深处反复灌酒精、双氧水或高浓度消毒剂; 不要为了“杀菌”把伤口烧灼。

升级/危险信号: 红肿持续扩大、脓液、发热、红线向上延伸、伤口深到看见脂肪/肌腱或持续出血。

深切口/撕裂伤 / Deep laceration

怎么认: 伤口明显张开、边缘分离, 或可见黄色脂肪/更深组织; 可能持续渗血。

立刻做: 先彻底止血和大量冲洗; 覆盖干净不粘敷料。灾难长期断医时, 也不要急着把污染很重、咬伤、穿刺伤强行缝死。

用什么: 生理盐水/清洁水、纱布、不粘敷料、压力绷带。若伤口已经完全止血、充分冲洗、直线、边缘可轻松合拢、张力低, 且不是咬伤/刺伤/重污染伤, 可用 Steri-Strips 免缝胶带。复方安息香酊只涂在伤口两侧完整皮肤以增强黏性, 不能涂进伤口。

不要做: 普通人不要缝合深部污染伤口; 不要用 Steri-Strips 强行闭合咬伤、刺伤、感染/污染伤或张力大的伤口; 不要把伤口里的深层异物用工具乱挖。

升级/危险信号: 肌腱/神经受损(手指不能动、麻木)、持续大出血、伤口位于脸/手/关节附近、明显污染或感染。

穿刺伤 / Puncture wound

怎么认：钉子、针、尖锐物留下的小孔，表面可能不大但深部污染风险高。

立刻做：让伤口自然流出少量血后彻底冲洗，覆盖干净敷料；核对破伤风疫苗状态。

用什么：清洁水/生理盐水、敷料；破伤风疫苗记录。

不要做：不要因为外面只有一个小孔就认为“没事”；不要自行把深部穿刺伤封死。

升级/危险信号：脚底穿刺、深部异物、明显污染、红肿扩大、发热、疼痛加剧，或糖尿病/免疫低下。

猫狗/人咬伤 / Bite wound

怎么认：牙齿造成穿刺/撕裂，尤其猫咬手部时表面小但深部感染风险高。

立刻做：立即用大量流动水和肥皂充分清洗，再冲洗；覆盖而不是紧闭。按预设方案评估阿莫西林/克拉维酸（Amoxicillin/Clavulanate）及破伤风风险。

用什么：肥皂和水、冲洗液、敷料；处方预案。

不要做：不要用胶水/缝线把新鲜咬伤紧密封闭；不要给猫/狗伤口反复挤压。

升级/危险信号：手部/脸部/关节附近咬伤、深穿刺、红肿扩散、脓液、发热；来源动物狂犬病风险不明时必须另行评估。

破伤风风险 / Tetanus wound check

怎么认：穿刺、咬伤、泥土/粪便/唾液污染伤、烧伤、开放性骨折、挤压伤、冻伤都属于更高风险伤口。

立刻做：把“上次Td/Tdap是什么时候、基础免疫是否完整”写进手册。所有伤口都要清洁并去除明显污物。需要疫苗/破伤风免疫球蛋白的情况应按当地指南和既往免疫史判断。

用什么：疫苗记录卡。

不要做：不要口服/外用抗生素“预防破伤风”来替代疫苗/免疫球蛋白；抗生素并不是破伤风暴露后的常规预防手段。

升级/危险信号：免疫史不清 + 污染/深部伤口；出现张口困难、肌肉强直/痉挛属于危重。

6B-3. 骨折、脱臼、扭伤与挤压伤**疑似骨折 / Suspected fracture**

怎么认：明显畸形、剧烈疼痛和肿胀、不能负重/活动、骨头外露，或受伤后手脚远端变白/发紫/冰冷。

立刻做：先处理出血。尽量保持发现时的位置，用夹板固定受伤部位以及上下相邻关节；固定前后检查远端颜色、温度、感觉和活动。开放骨折用干净敷料覆盖伤口。

用什么：SAM夹板/硬板、软垫、三角巾、绷带、敷料。

不要做：普通人不要强行把明显畸形“掰直”或把露出的骨头塞回去；绑带不要勒到手脚发麻发紫。

升级/危险信号：开放骨折；大腿骨/骨盆疑似骨折；手脚发白/发紫/冰冷；明显麻木或无法活动。

扭伤/拉伤 / Sprain & strain

怎么认：扭伤后局部疼、肿、淤青，但通常没有明显骨畸形；还能部分活动。

立刻做：停止继续使用受伤部位；可用冷敷减痛消肿，每次约10-20分钟，外面包布；弹力绷带轻度加压，抬高如果不增加疼痛。

用什么：冷敷包、弹力绷带。

不要做：不要把弹力绷带缠到远端发麻/发紫；不要把“还能走”当作排除骨折。

升级/危险信号：完全无法负重、明显畸形、麻木/血流异常、疼痛越来越重，或48-72小时几乎不改善。

疑似脱臼 / Dislocation

怎么认：关节明显变形、固定在异常角度、剧烈疼痛、几乎不能活动。

立刻做：保持原位，用软垫和夹板/吊带固定；检查远端手指/脚趾颜色、温度、感觉。

用什么：夹板、三角巾、软垫。

不要做：普通人不要强行复位；不要反复拉拽关节“试试看”。

升级/危险信号：远端发白/发紫/冰冷、无脉/麻木、开放伤口或剧痛。

挤压伤 / Crush injury

怎么认：建筑物/重物压住肢体或身体，时间较长；局部严重肿胀、疼痛、麻木，后续可能全身乏力或尿色变深。

立刻做：在确保环境安全后解除压迫，处理明显出血，保持伤员平卧保暖并持续监测。长时间挤压伤即使表面伤口不大，也按高风险处理。

用什么：本套装：[1]/[10]/[11]/[12]止血用品 + [6]夹板 + [7]急救毯 + [13]TCCC 伤员卡。

不要做：不要因为“压出来以后还能说话”就放松警惕；不要让严重挤压伤员自己走动。

升级/危险信号：肢体越来越紧硬、疼痛远超外观、麻木/无力、远端血流差、深色尿、意识变化。

6B-4. 头部、颈背与脊柱**脑震荡 / Concussion**

怎么认：撞头后出现头痛、恶心、头晕、平衡差、反应慢、记忆模糊、注意力下降；不一定会晕倒。

立刻做：立即停止运动/工作，避免再次撞击；让伤员安静休息并有人陪同观察。每隔一段时间确认能正常交流、走路/肢体活动没有明显新变化。

用什么：记录表、冰袋（头皮肿包可隔布冷敷）。

不要做：不要让伤员继续运动、开车或喝酒；不要因为“没晕倒”就排除脑震荡。

升级/危险信号：意识丧失、反复呕吐、头痛持续加重、抽搐、越来越嗜睡/迷糊、视力改变、瞳孔明显不等大、肢体无力。

疑似颈椎/脊柱伤 / Suspected spinal injury

怎么认：高处坠落、头颈受重击、车辆撞击后出现颈背痛、麻木、无力，或不能感觉/移动手脚。

立刻做：让伤员保持尽量不动，头颈躯干维持自然位置；只有现场不安全、需要保持气道或必须转移时才移动。

用什么：毛毯/垫物；多人整体移动时的协调口令。

不要做：普通人不要常规给所有人套硬颈托或绑在硬板上；不要扭头测试活动度。

升级/危险信号：任何新发麻木、无力、大小便控制异常、呼吸困难或意识改变。

头皮大量出血 / Scalp wound

怎么认：头皮伤口看起来可能“血很多”，但头骨凹陷/异物/疑似骨折时处理不同。

立刻做：没有明显头骨凹陷或穿透时可用干净纱布直接压迫止血。若怀疑头骨骨折/异物，改为在伤口周围轻压并覆盖。

用什么：本套装：[10]/[11]纱布 + [12]急救创伤绷带。

不要做：不要在明显凹陷、骨片或异物上用力往下压；不要拔除嵌入物。

升级/危险信号：伴意识改变、呕吐、抽搐、神经症状或高能量撞击。

6B-5. 胸部、腹部与骨盆：不要被“表面没有血”骗过

胸部穿透伤 / Open chest wound

怎么认：胸壁有开放伤口，可能随呼吸出现气流声/冒泡，并伴胸痛或呼吸困难。

立刻做：这是危重。可让伤口保持开放；或盖干净、不密闭的干敷料；若有训练和专用器材可使用带排气孔本套装[9]胸封。持续观察呼吸。

用什么：干净纱布；带排气孔本套装[9]胸封（如已受训）。

不要做：不要用普通塑料把胸伤完全密封后就不再观察；若覆盖后呼吸明显变差，应松开/移除覆盖物。普通人不要做针减压（本套装[3] 14G 胸腔针仅限专业人员）。

升级/危险信号：任何呼吸困难、发绀、意识变差、胸痛加重。

钝性胸伤 / Blunt chest trauma

怎么认：重物撞胸、跌落、方向盘撞击后胸痛，深呼吸/咳嗽更痛，可能呼吸变浅。

立刻做：让伤员取最容易呼吸的体位，减少活动，观察呼吸频率/血氧（若有）；可用对乙酰氨基酚（Acetaminophen）镇痛。

用什么：血氧仪、记录表、对乙酰氨基酚。

不要做：不要用很紧的绷带把整个胸廓勒住；不要用镇静药压住呼吸困难。

升级/危险信号：呼吸越来越困难、SpO2 下降、咳血、意识变化或休克。

腹部内伤/内出血 / Abdominal injury

怎么认：撞击/坠落后持续或加重的腹痛、腹部发硬/膨胀、肩部牵涉痛、头晕苍白、心跳快；外表可能没有血。

立刻做：平卧保暖，尽量少移动；持续记录意识、心率、血压（若有）。如果可能需要手术/撤离，不要大量进食。

用什么：毛毯、生命体征记录。

不要做：不要反复用力按肚子“找痛点”；不要因为止痛后暂时好一点就忽略恶化趋势。

升级/危险信号：持续加重腹痛、晕厥/近晕厥、血压下降、腹部越来越硬或明显膨胀、呕血/血便。

疑似骨盆骨折 / Pelvic injury

怎么认：高能量挤压/坠落后髋部、腹股沟或骨盆剧痛，不能站立，可能伴休克。

立刻做：让伤员保持原位、减少搬动并保暖；把它当作可能存在大量内出血的伤处理。

用什么：毛毯、担架/硬质转运板（仅用于搬运）。

不要做：不要让伤员“试着站起来走两步”；不要反复挤压骨盆测试稳定性。

升级/危险信号：任何休克表现、血尿、下肢麻木/血流异常。

6B-6. 烧伤、电击与化学伤

热烧伤/烫伤 / Thermal burn

怎么认：红、痛、起泡；更深时皮肤可发白、焦黑、感觉反而减弱。

立刻做：脱离热源，尽快用凉的流动水冷却约 5-20 分钟；尽早取下戒指、手表、皮带等紧物。小面积开放烧伤冷却后可薄涂凡士林并用不粘敷料覆盖。

用什么：流动水、凡士林、不粘敷料、对乙酰氨基酚/布洛芬（无禁忌时）。

不要做：不要用冰直接贴；不要抹牙膏/黄油；不要撕下粘住皮肤的衣物；不要自行挑破完整水泡。

升级/危险信号：全层烧伤；超过本人一个手掌大小的部分厚度烧伤；面、手、脚、生殖器；环形烧伤；烟雾吸入/面部烧伤/鼻口煤灰。

化学品泼到皮肤 / Chemical skin exposure

怎么认：皮肤接触酸、碱、清洁剂、工业化学品后灼痛、变色或起泡。

立刻做：先保护施救者。干粉先轻轻刷掉，避免把粉末带到更多皮肤；多数液体化学品随后用大量流动水持续冲洗并脱掉受污染衣物。

用什么：手套、大量清洁水、剪刀、密封袋装污染衣物。

不要做：不要随意用另一种化学品“酸碱中和”；不要让污染水流到未受伤皮肤/另一只眼。

升级/危险信号：大面积、持续疼痛、全层损伤、吸入化学气体或不清楚化学品性质。

电击伤 / Electrical injury

怎么认：接触电源后倒地、烧伤、心悸、意识异常；外面伤口可能很小但内部损伤很重。

立刻做：先切断电源/确认环境安全再接触伤员。检查反应和正常呼吸；无正常呼吸按 CPR/AED 流程。覆盖可见烧伤并持续观察。

用什么：AED、绝缘环境控制、烧伤敷料。

不要做：电源未切断前不要直接徒手碰人；不要因为皮肤只有一个小烧点就认为损伤轻。

升级/危险信号：高压电、雷击、晕厥、胸痛/心悸、神经症状、任何心搏骤停。

6B-7. 眼、鼻与牙齿外伤

眼睛进灰尘/小异物 / Low-energy eye foreign body

怎么认：风吹沙尘、睫毛、小颗粒造成明显异物感，但没有高速金属/玻璃撞击、没有眼球出血/变形。

立刻做：不要揉眼；先让眼泪自然冲出，或用大量干净水/生理盐水低压冲洗。隐形眼镜取下。

用什么：0.9%生理盐水/干净水。

不要做：不要用镊子去夹角膜上的东西；不要揉眼。

升级/危险信号：冲洗后仍明显疼/异物感；视力下降；高速打磨/钉枪/金属碎屑；瞳孔形状异常；眼球出血。

化学品入眼 / Chemical eye exposure

怎么认：清洁剂、酸碱、化学液体/粉末进入眼睛后灼痛、流泪、睁不开。

立刻做：立刻冲洗，不要等待。用大量自来水/生理盐水持续至少 15 分钟；让受伤眼位于较低位置，避免污染另一只眼和施救者。

用什么：大量水/生理盐水；手套。

不要做：不要先花时间寻找“中和液”；不要揉眼。

升级/危险信号：冲洗后仍剧痛、视力变化、角膜混浊或强酸/强碱暴露。

眼球穿透/高速眼伤 / Penetrating eye injury

怎么认：高速金属/玻璃、尖锐物刺入；眼球出血、瞳孔形状异常、突然视力下降。

立刻做：不要压眼。用硬质眼罩/干净纸杯罩住受伤眼，防止误碰，尽量减少眼球运动。

用什么：硬质眼罩/纸杯 + 胶带。

不要做：不要拔出异物；不要冲洗穿透伤；不要用眼垫直接压迫眼球。

升级/危险信号：所有疑似穿透伤/突然视力下降。

鼻出血 / Nosebleed

怎么认：血从鼻孔流出，多数来自鼻前部。

立刻做：坐直并身体略前倾，用拇指食指捏住鼻翼柔软部分持续 10-15 分钟，中途不要反复松手检查。

用什么：纸巾/纱布、冷敷包（舒适用）。

不要做：不要仰头吞血；不要把纸巾塞很深；不要几分钟就松手看。

升级/危险信号：20 分钟左右持续不止、出血量大、抗凝药使用者、伴明显头面部外伤或呼吸困难。

恒牙被撞掉 / Avulsed permanent tooth

怎么认：整颗恒牙从牙槽里脱落；儿童乳牙不要尝试植回。

立刻做：只拿牙冠，不碰牙根。明显脏时轻柔短暂冲洗，不刷洗；如果伤员清醒合作且能立即就医，可按受训方案尝试原位放回；否则优先放入合适保存介质并尽快找牙科。

用什么：牙齿保存液（如有）或牛奶；干净容器。

不要做：不要把牙齿放干纸巾里很久；不要刷洗牙根；不要把乳牙塞回去。

升级/危险信号：恒牙完全脱落属于时间敏感的牙科急症。

6C. 环境急症 / Environmental Emergencies

长期停电/地震后，低体温、一氧化碳和热病可能比很多感染更快致命。这里仍使用“怎么认 -> 立刻做 -> 不要做 -> 升级”的普通人模式。

低体温 / Hypothermia

怎么认：持续受冷后发抖、动作笨拙、说话含糊、判断力差；更严重时反而停止发抖、嗜睡/意识下降、呼吸和心率变慢。

立刻做：移到避风干燥处；脱下湿衣、擦干、换干衣并包裹头部和躯干。优先温暖胸腹躯干；清醒且能吞咽的人可喝温热含糖饮料/进食高热量食物。中重度者轻柔搬动。

用什么：干衣、睡袋/毯子、隔水层、包布的温水袋/大号化学热包。

不要做：不要用很烫的水浸泡全身；不要按摩冰冷四肢；不要喝酒“取暖”。

升级/危险信号：意识下降、停止发抖、呼吸/心率异常、走不了路 = 中重度低体温。

冻伤 / Frostbite

怎么认：手指、脚趾、耳鼻等变麻、蜡样、发白/灰黄/蓝，严重时变硬。

立刻做：先处理全身低体温。确认不会再次冻结时，用约 37-40°C 干净温水缓慢复温；取下戒指等紧物，复温后用蓬松干纱布松松分隔手指/脚趾。

用什么：温度可控的温水、干纱布、布洛芬（Ibuprofen，若无禁忌）。

不要做：有再次冻结风险时不要先解冻；不要用火炉/暖气片直接烤；不要揉搓/用雪摩擦；不要挑破水泡。

升级/危险信号：明显水泡、深色/黑色、大片冻伤、伴中重度低体温。

热衰竭 vs 中暑 / Heat exhaustion vs heat stroke

怎么认：热衰竭：大汗、乏力、头晕恶心但意识基本清楚。中暑：高热环境下出现意识混乱、抽搐、行为异常或昏迷，出汗可以有也可以没有。

立刻做：热衰竭：移到阴凉处、脱多余衣物、冷敷并口服补液盐（ORS）/电解质液。疑似中暑：立即快速降温；能做时冷水浸泡躯干是高效方法，同时启动救援。

用什么：ORS/电解质液、冷水、冰袋、风扇。

不要做：意识异常的人不要强行灌水；不要只吃退烧药等待。

升级/危险信号：任何意识异常/抽搐/昏迷 = 中暑，属于危重。

一氧化碳中毒 / Carbon monoxide poisoning

怎么认：头痛、头晕、乏力、恶心呕吐、胸痛或意识混乱；一家多人同时“像感冒”尤其可疑。燃气设备、发电机、炭火在室内/车库使用是重大线索。

立刻做：在不让自己中毒的前提下立即离开污染环境，到新鲜空气处并启动救援。关闭污染源只在安全且不会耽误撤离时进行。

用什么：CO 报警器；新鲜空气；氧气仅限有合适设备和训练时。

不要做：不要进入高浓度环境“救人”而没有呼吸防护；普通血氧仪可能看起来正常，不能用来排除 CO 中毒。

升级/危险信号：晕厥、胸痛、神经症状、呼吸困难、孕妇或持续症状。

6C-5. 浸渍足/战壕足：温哥华湿冷环境高价值模块

预防：脚必须“轮换干燥”。每天至少检查 2 次；一旦袜子湿透就换。两名成人建议储备 4-6 双保暖羊毛/合成纤维袜，并留一组永远保持干燥。鞋垫能取出就晾干。

现场处理：湿鞋湿袜脱掉 -> 擦干 -> 抬高 -> 通风 -> 换干袜 -> 减少负重行走。不要把麻木脚直接贴暖炉、热水袋或火源。

物资：备用羊毛袜、干燥鞋垫/鞋、足粉或吸湿粉、干毛巾、透气拖鞋/营地鞋。足粉的作用是防潮，不是治疗已经发生的组织损伤。

危险：水疱、皮肤变灰紫/黑、持续麻木、肿痛迅速加重、伤口/溃疡、恶臭或发热 -> 说明已经超出单纯“湿脚”。

6D. 普通人外伤“不要做” + 复评 / Layperson Do-Not-Do & Recheck

当没有医疗系统时，人最容易犯的错误往往不是“少做一步”，而是做了超出训练水平的侵入性操作。下面这些默认不要做。

- **不要自行复位明显骨折/脱臼。** 夹板固定原位比“掰回去”更安全。
- **不要自行缝合深部污染伤、咬伤或穿刺伤。** 先止血、冲洗、覆盖和观察感染。
- **不要拔出深部嵌入异物。** 尤其胸、腹、颈、眼部。
- **不要给普通人做针减压、胸腔穿刺、气管切开或深部脓肿切开。** 这些不是靠文字手册能安全掌握的技能。
- **不要给无意识/吞咽不安全的人灌水、食物或口服药。**
- **不要为了止痛把所有症状压下去后停止观察。** 头伤、腹伤、内出血、严重感染最重要的是趋势。
- **不要把“血压正常”当作没有休克。** 早期休克可先表现为心率快、冷汗、脸白、焦躁、尿量下降。
- **不要在外伤后让严重疼痛/头晕/呼吸困难者自己走。**

外伤复评：每 15-30 分钟重新看一遍（稳定后可拉长间隔）

- **意识：**能否正常回答姓名、地点、发生了什么？有没有越来越嗜睡/混乱？
- **呼吸：**有没有越来越快/越来越费力？胸伤覆盖后是否变差？
- **循环：**皮肤是否越来越苍白/冷汗？心率是否升高？血压是否下降？
- **止血：**敷料下面是否重新大量出血？止血带是否仍有效？

- **肢体血流/神经：**夹板后手指/脚趾颜色、温度、感觉和活动是否变差？
- **疼痛和肿胀：**是否“明显越来越痛”、肢体变得坚硬、腹部越来越硬/胀？
- **记录：**伤情发生时间、止血带时间、所有用药、最后一次进食饮水、过敏史、疫苗史。

外伤用品 -> 用在哪里（最短版）

套装物品	主要用途	关键提醒
[1] 绞棒式止血带	四肢危及生命的大出血	伤口上方约 5-7 cm、避开关节；旋紧到出血停止；记录时间
[2] 创伤剪	快速暴露伤口	钝头朝皮肤，避免盲剪
[10]/[11] 压缩纱布	直接压迫、深伤口填塞	深洞要真正填满并持续强压
[12] 4 英寸急救创伤绷带	维持压力、固定敷料	不能替代止血带或深伤口填塞
[6] 18 英寸夹板	骨折/严重扭伤临时固定	不复位；固定前后查远端血流/感觉
[5] 三角巾	上肢悬吊、辅助固定	不要勒住颈部
[7] 急救毯	防失温/休克保暖	不要盖住口鼻
[9] 胸封	开放性胸壁伤的特定处理	优先确认是否排气型；贴后更端要松开/移除
[3] 14G 胸腔针	仅供受训专业人员	普通人不要使用
[13] TCCC 伤员卡	记录止血带时间和伤情变化	建议旁边固定永久记号笔

本外伤章节依据：2024 AHA/American Red Cross First Aid Guidelines、2025 ACS STOP THE BLEED 课程、CDC 2026 破伤风伤口管理、CDC 2026 一氧化碳资料、AHA 2025 成人 BLS。真正的技能（CPR、AED、止血带、伤口填塞）最好灾前完成实体课程并反复练习。

- American Heart Association / American Red Cross. 2024 Guidelines for First Aid - severe bleeding, open chest wounds, fractures, concussion, spinal motion restriction, burns, chemical eye injury, hypothermia, frostbite and heat illness.
- American Heart Association. 2025 Adult Basic Life Support - lay-rescuer CPR/AED, adult chest compression rate 100-120/min and depth about 5-6 cm.
- American College of Surgeons. STOP THE BLEED Version 3.0 (2025) - direct pressure, wound packing, tourniquet placement and recording application time.
- CDC. Clinical Guidance for Wound Management to Prevent Tetanus (reviewed 2026) - contaminated wound categories, cleaning and vaccination/immune globulin logic; antibiotics are not tetanus prophylaxis.
- CDC. Carbon Monoxide Poisoning Basics (2026) - symptoms, generator/combustion risks and immediate removal to fresh air.

6E. 离线防感染与环境控制 / Offline Infection Prevention & Sanitation

目标：先阻断“水 -> 手 -> 食物 -> 口”和“呕吐物/粪便 -> 手/表面 -> 口”的传播链。剧烈呕吐或水样腹泻出现后，先隔离污染，再补液；不要把抗生素当作环境卫生的替代品。

6E-1. 离线安全水制备标准

- 【前置物理过滤】浑浊水或疑似污水倒灌后的水，先静置/粗滤，再使用重力净水器（微滤 + 活性炭滤芯）降低颗粒、原虫和部分细菌负荷；活性炭主要改善异味/口感并减少部分化学物。
- 重力微滤不是最终消毒：不能可靠去除所有病毒。污水污染场景下，过滤后仍要煮沸或按漂白水法消毒；怀疑燃油、农药、溶剂、重金属污染时直接换水源。
- 【首选：煮沸】浑水先静置/用干净布、咖啡滤纸过滤。清水达到持续翻滚沸腾后：海拔 <= 约 2000 m（6500 ft）继续沸腾至少 1 分钟；高于约 2000 m 继续至少 3 分钟。自然冷却，装入干净有盖容器。
- 【漂白水备用】只用普通、无香精、无增白/清洁添加剂的液体家用漂白水；标签有效成分为次氯酸钠（Sodium hypochlorite）约 5%-9%。
- 每 1 L 清澈水：2 滴；每 1 L 浑浊、带颜色或很冷的水：先尽量过滤，再加 4 滴。搅匀，盖住，静置至少 30 分钟后再喝。
- 30 分钟后完全没有轻微氯味：再按原剂量加一次，继续等 15 分钟。
- 漂白水法对部分寄生虫（尤其隐孢子虫，且对贾第虫不如煮沸可靠）较弱；有条件优先“过滤 -> 煮沸”或按净水产品标签过滤/消毒。
- 燃油、溶剂、农药、重金属、放射性污染的水：煮沸和漂白水都不能把它变安全；换水源。

防呆：饮用水用的漂白水剂量非常低；不要把下面“清理呕吐物”的高浓度消毒液拿来饮用。所有消毒桶/瓶必须写大字“不可饮用”。

6E-2. 隔离、双桶厕所与呕吐物清理

- 【有人剧烈呕吐/水样腹泻】立即划出“病人区”；病人单独使用杯子、餐具、毛巾和厕所/便桶。病人不要准备全家食物；症状停止后至少 48 小时仍不要给别人准备食物。
- 【双桶干式厕所】准备 2 个带盖 15-20 L 桶：一个写“尿”，一个写“便”。尽量不要混合，能明显减轻臭味和废物体积。
- “便桶”：套 2 层厚垃圾袋；底部先铺木屑/猫砂/碎纸。每次排便后再撒一层干燥吸收物，把粪便表面完全盖住；厕纸也放便桶。袋子约半满就扎紧并再套一层袋，放入有盖、防鼠、防宠物接触的二次容器，远离食物和饮水。城市住宅优先密封储存到垃圾/污水处理恢复，不要倒入雨水井或地表水。
- “尿桶”：只收尿，盖好；厕纸仍放“便桶”。如确实需要在户外处置，优先倒在远离饮水、食物区、通道和雨水井的土壤/草地，并分散少量处置。不要把漂白水、漂白粉、生石灰直接倒进尿/粪桶；尤其不要把含氯漂白剂与尿液、氨类清洁剂或酸性清洁剂混合，可能释放刺激性有毒气体。
- 厕所旁固定放：肥皂 + 安全水 + 纸巾。每次如厕/处理垃圾袋后，用肥皂和水搓洗双手至少 20 秒；诺如病毒场景下，免洗手消毒液不能替代肥皂洗手。
- 【呕吐物清理 - 严格防护】先让其他人和猫离开并通风。清理者戴一次性手套 + 口罩 + 护目镜/面屏；有条件再穿可清洗围裙或一次性外层。不要跪在污染物正上方，不要用吸尘器、扫把猛扫或大力刷洗把飞沫扬起来。
- 先用一次性纸巾/吸收材料从外向内“盖住并吸起”，不要来回擦散；污染物和纸巾立即装袋封口。再用清洁剂把肉眼可见污物完全去掉，之后才进入消毒步骤。
- 硬质非多孔表面：用对诺如有效的成品消毒剂，或用 1000-5000 ppm 含氯消毒液。若原液为约 5% 次氯酸钠，约等于每 1 L 水加入 20-100 mL 漂白水；污染重时用较高浓度。让表面保持湿润至少 5 分钟，再用肥皂/热水清洁。含氯液绝不与氨、尿液、醋/酸性清洁剂混合。
- 被污染衣物/床单：戴手套，轻拿轻放，不要抖；单独装袋转移，用洗衣液 + 可用的最高温/最长程序洗，彻底烘干。脱下外层防护和手套时不要碰污染面；最后用肥皂和安全水洗手至少 20 秒。

最关键的“断传染链”动作：安全水、肥皂洗手、病人不做饭、呕吐/粪便立即清除并消毒、厕所与厨房分区。

6F. 女性卫生与非创伤性眼科急症 / Women's Hygiene & Eye Illness

女性卫生：灾害期优先外置卫生巾（Pads）；勤更换，保持外阴和内裤干燥。不要自制内置棉条，不做阴道灌洗。

霉菌 vs BV：强烈瘙痒 + 厚白分泌物更像霉菌；明显鱼腥味 + 薄灰白分泌物更像 BV。两者会重叠，没有化验时不要把症状当成 100% 诊断。

TSS：使用棉条/阴道内用品期间突然高热、呕吐/腹泻、大片红疹、极度虚弱、站立头晕或快晕倒 -> 立即取出内置物，保暖平躺，按严重全身感染/休克处理。

储备：外置卫生巾、无香清洁用品、透气内裤、克霉唑（Clotrimazole）阴道制剂；氟康唑（Fluconazole）只作为预设处方药。

雪盲：雪地/强 UV 暴露后数小时双眼剧痛、流泪、畏光 -> 停止暴露、暗处休息/UV400 太阳镜、冷敷、人工泪液、口服普通止痛药。

红眼病隔离：肥皂洗手 20 秒；毛巾/枕巾/眼药水不共用；分泌物用一次性干净材料清理；不要揉眼；停戴隐形眼镜。

抗生素眼膏：病毒性红眼不需要抗生素。明显脓性分泌物且已有医生预设时才使用红霉素眼膏（Erythromycin ophthalmic ointment）。

眼科危险信号：视力下降、明显眼痛、强烈畏光、角膜白点/浑浊、瞳孔异常、单眼剧烈疼痛伴头痛恶心 -> 不按普通结膜炎/雪盲继续观察。

7. 药物总表 A: 抗感染 / Anti-infective Formulary (中英双语)

阿莫西林/克拉维酸 Amoxicillin/Clavulanate (Augmentin)	
级别	Rx P1
核心用途	咬伤、牙源感染、细菌性鼻窦炎、部分蜂窝织炎/呼吸道感染
主要限制/储存	β -lactam 过敏；易腹泻；片剂防潮，勿储备已复悬液

阿莫西林 Amoxicillin	
级别	Rx P1/P2
核心用途	确诊链球菌咽炎；部分牙源感染；低风险 CAP 的一线之一
主要限制/储存	不是所有咽痛都适用；严重青霉素过敏禁用

多西环素 Doxycycline	
级别	Rx P1
核心用途	部分 CAP/非典型感染、部分 MRSA 皮肤感染、蜱传/立克次体病
主要限制/储存	与铁/钙/镁/抗酸剂错开；大量水送服并保持直立；妊娠需评估

复方磺胺甲噁唑 TMP-SMX / Co-trimoxazole	
级别	Rx P1
核心用途	部分单纯 UTI、MRSA/化脓性皮肤感染
主要限制/储存	磺胺过敏、肾病、高钾风险/药物相互作用

阿奇霉素 Azithromycin	
级别	Rx P1
核心用途	重症旅行者腹泻/痢疾、百日咳、部分非典型呼吸道感染；部分 CAP 联合方案
主要限制/储存	QT 延长/心律问题；不作为普通鼻窦炎经验首选

奥司他韦 Oseltamivir (Tamiflu)	
级别	Rx P1
核心用途	Influenza A/B；治疗越早通常越有价值
主要限制/储存	肾功能下降需调整；不是广谱抗病毒药

头孢氨苄 Cephalexin	
级别	Rx P2
核心用途	非化脓性蜂窝织炎/MSSA、部分 UTI
主要限制/储存	不可靠覆盖 MRSA；严重 β -lactam 过敏需评估

甲硝唑 Metronidazole	
级别	Rx P2
核心用途	Giardia、部分厌氧感染；H. pylori 四联的一部分
主要限制/储存	不是普通腹泻万能药；注意相互作用

呋喃妥因 Nitrofurantoin	
级别	Rx P2
核心用途	单纯性膀胱炎
主要限制/储存	不能用于肾盂肾炎；肾功能影响选择

阿苯达唑片 Albendazole	
级别	Rx/视地区 P2
核心用途	常见肠道蠕虫：蛲虫、蛔虫、钩虫、鞭虫；不是普通腹泻药
主要限制/储存	妊娠/可能妊娠和肝病需谨慎；长期/复杂寄生虫病需要医疗监测；片剂室温干燥保存

四环素 Tetracycline	
级别	Rx 条件
核心用途	H. pylori 优化铋剂四联方案核心药之一
主要限制/储存	不要把 多西环素（Doxycycline）自行等价替代；与矿物质/抗酸剂相互作用

克霉唑 1% Clotrimazole 1%	
级别	OTC P1
核心用途	脚癣、股癣、体癣、皮肤念珠菌
主要限制/储存	外用；保持患处干燥

莫匹罗星 Mupirocin	
级别	Rx P2
核心用途	局限性脓疱疮/表浅细菌感染
主要限制/储存	不能处理深部蜂窝织炎或脓肿
杆菌肽/多黏菌素 B（Polysporin） Bacitracin/Polymyxin B	
级别	OTC
核心用途	小面积表浅擦伤/切口在清洗后需要短期局部抗菌覆盖时可用；不是每个干净伤口都必须用。
主要限制/储存	先用清水/生理盐水充分清洗；干净小伤口通常凡士林 + 不粘敷料即可。出现皮疹/瘙痒停用；不用于深刺伤、大面积烧伤、深部感染或脓肿。
克霉唑阴道制剂 Clotrimazole vaginal	
级别	OTC
核心用途	典型无并发症霉菌性阴道炎：明显瘙痒/灼热 + 较厚白色分泌物，通常无明显鱼腥味。
主要限制/储存	按具体产品包装完成疗程；不治疗细菌性阴道病（BV）。首次发作、反复发作、发热/下腹痛、异常出血或可能怀孕时不要只靠症状硬猜。
氟康唑 Fluconazole	
级别	Rx
核心用途	医生预设时用于无并发症霉菌性阴道炎；作为口服备用方案。
主要限制/储存	怀孕或可能怀孕时不要自行口服；有肝病、心律问题或多种处方药时需先核对相互作用。
红霉素眼膏 Erythromycin ophthalmic ointment	
级别	Rx
核心用途	医生预设的细菌性结膜炎等表浅眼部细菌感染。
主要限制/储存	病毒性红眼通常无效。眼痛、强烈畏光、视力下降、角膜白点/浑浊时不能靠眼膏拖延。
人工泪液 Artificial tears	
级别	OTC
核心用途	雪盲、病毒性结膜炎、干眼的支持治疗。
主要限制/储存	优先无防腐剂单支装；多人之间不共用已开封瓶，瓶口不要碰眼睛。

伐昔洛韦 Valacyclovir	
级别	Rx 条件
核心用途	HSV、带状疱疹；适合有明确既往史者的个人模块
主要限制/储存	用途较专一；肾功能影响剂量

8. 药物总表 B：支持/对症与急救 / Supportive & Emergency Medicines

口服补液盐 Oral Rehydration Salts (ORS)	
级别	OTC P0
核心用途	腹泻、呕吐、高温/大量出汗导致脱水
关键限制	严格按包装水量配；最怕潮

肾上腺素自动注射器（EpiPen 0.3 mg） Epinephrine Auto-Injector	
级别	药房可购/OTC P0
核心用途	严重过敏性休克一线。成人常用 0.3 mg：橙色端贴大腿外侧，可隔衣注射，按装置说明压住约 3 秒
关键限制	注射后仍需启动救援/撤离；若 5-15 分钟无改善或恶化，且有第二支，可再次使用。15-30°C 避光保存，勿冷藏/冷冻

沙丁胺醇 Salbutamol / Albuterol inhaler + spacer	
级别	Rx P1
核心用途	哮喘/支气管痉挛/喘鸣
关键限制	不能替代严重过敏性休克中的肾上腺素；气雾罐怕高温

昂丹司琼 ODT Ondansetron ODT	
级别	Rx P1
核心用途	严重恶心呕吐，帮助恢复口服补液
关键限制	QT 风险；ODT 原泡罩防潮

茶苯海明 Dimenhydrinate (Gravol)	
级别	OTC P2
核心用途	晕车/晕船、交通颠簸或其他运动诱发的恶心、呕吐和眩晕；补齐昂丹司琼对前庭性症状覆盖不足。
关键限制	常见嗜睡、反应变慢；服后不要驾驶、操作发电机/刀具；不要与酒精或其他镇静药随意叠加。按加拿大产品标签使用。

对乙酰氨基酚 Acetaminophen / Paracetamol	
级别	OTC P1
核心用途	发热、头痛、牙痛、外伤疼痛
关键限制	肝病/大量饮酒需谨慎；检查复方药重复成分

布洛芬 Ibuprofen	
级别	OTC P1
核心用途	疼痛 + 发热 + 抗炎
关键限制	GI 出血、明显脱水、肾病等情况下避免

埃索美拉唑 Esomeprazole (Nexium)	
级别	OTC/Rx P1
核心用途	GERD、胃炎/溃疡抑酸；GI 出血仅辅助
关键限制	肠溶剂型防潮；不是机械止血药

法莫替丁 Famotidine (Pepcid)	
级别	OTC P2
核心用途	较快抑酸、夜间/间歇性反酸；LPR/GERD 辅助
关键限制	肾功能下降需留意剂量

海藻酸盐屏障 Sodium Alginate / Gaviscon-type	
级别	OTC P2
核心用途	反流/LPR 的物理屏障，饭后/睡前尤其有用
关键限制	不同地区配方钠含量不同

洛哌丁胺 Loperamide (Imodium)	
级别	OTC P1
核心用途	无血、无明显高热的水样腹泻
关键限制	血便/明显发热时不要单药使用

次水杨酸铋 Bismuth Subsalicylate	
级别	OTC P2
核心用途	腹泻、消化不良；部分 H. pylori 方案可用铋剂
关键限制	活动性 GI 出血/水杨酸盐风险时不要自行使用

西替利嗪 Cetirizine	
级别	OTC P1
核心用途	荨麻疹、虫咬、过敏性鼻炎
关键限制	不能替代肾上腺素

氟替卡松鼻喷 Fluticasone nasal spray	
级别	OTC/药房 P1/P2
核心用途	过敏性鼻炎、鼻后滴流；慢性咽部刺激的重要模块
关键限制	需要规律使用；喷头方向避开鼻中隔

泼尼松 Prednisone	
级别	Rx P2
核心用途	特定哮喘急性加重/严重炎症或过敏辅助
关键限制	免疫抑制、血糖等风险；只按个人预案

氢化可的松 1% Hydrocortisone 1% topical	
级别	OTC P2
核心用途	虫咬、轻度皮炎/湿疹
关键限制	不要长期用于面部/感染性皮炎
曲安奈德 0.1% 外用 Triamcinolone 0.1% topical	
级别	Rx P2
核心用途	医生预设用于中重度、明确非感染性的接触性皮炎/湿疹，填补 OTC 1% 氢化可的松与口服泼尼松之间的治疗空档。
关键限制	由医生预先写明部位、每天次数和最长天数；脸/眼周、腹股沟/生殖器、皮肤皱褶不要自行套用躯干四肢方案；疑似真菌/细菌感染、破溃伤口不要盲涂。

9. 条件性/舒适性模块 + 常用 OTC 成人参考 / Optional Modules & OTC Quick Reference

纳洛酮鼻喷 Naloxone nasal spray	
级别	药房 条件
适用场景	疑似阿片类过量：意识差 + 呼吸慢/停止；按产品说明重复
限制	用途单一但可救命；苏醒后仍需持续观察

咀嚼阿司匹林 Chewable Aspirin	
级别	OTC 条件
适用场景	仅用于医生预设的疑似急性冠脉综合征方案
限制	GI 出血、抗凝、某些过敏或疑似脑出血时不要自行用

右美沙芬 Dextromethorphan	
级别	OTC 可选
适用场景	影响睡眠的干咳/刺激性咳嗽
限制	不用于呼吸困难；与部分抗抑郁药有相互作用

愈创甘油醚 Guaifenesin	
级别	OTC 可选
适用场景	帮助稀释黏稠分泌物，配合补水
限制	收益有限但安全性较好；不是抗感染药

咽喉含片 薄荷醇/苯佐卡因含片（Menthol/Benzocaine Lozenges）	
级别	OTC 可选
适用场景	短期缓解急性/慢性咽喉刺激和疼痛
限制	只缓解症状；持续咽痛仍需找原因

碳酸钙抗酸剂 Calcium carbonate antacid	
级别	OTC 可选
适用场景	快速缓解短暂反酸/烧心
限制	与 多西环素（Doxycycline）/四环素（Tetracycline）等需错开

人工泪液 Artificial tears	
级别	OTC 可选
适用场景	干眼、灰尘/风刺激后的润滑
限制	化学品入眼应优先大量冲洗，不靠人工泪液

双氯芬酸外用凝胶 Topical diclofenac gel	
级别	OTC/药房 可选
适用场景	局部肌肉骨骼疼痛/关节痛，减少全身非甾体抗炎药（NSAID）暴露
限制	仍属于 非甾体抗炎药（NSAID）；大面积/破损皮肤或有非甾体抗炎药（NSAID）禁忌时慎用

聚乙二醇 3350 PEG 3350	
级别	OTC P2
适用场景	便秘，尤其饮食/活动改变后的常见便秘
限制	粉剂防潮；疑似肠梗阻、持续剧烈腹痛或反复呕吐时不要自行用

常用 OTC 成人参考（正常成人、无禁忌；优先以加拿大产品标签为准）

药物	常用参考	关键限制
对乙酰氨基酚（Acetaminophen）	650-1000 mg 每 6-8 h 按需；家庭自我用药通常把总量控制在 <=3000 mg/日	肝病、大量饮酒、复方感冒药重复成分需特别注意
布洛芬（Ibuprofen）	200-400 mg 每 6-8 h 按需；OTC 总量按产品标签	GI 出血、明显脱水、肾病/部分抗凝情况下避免
西替利嗪（Cetirizine）	10 mg 每日一次	可能嗜睡；肾功能下降时需考虑调整
埃索美拉唑 20 mg（Esomeprazole）	按 埃索美拉唑（Nexium 24HR）/产品标签，通常每日一次，短期疗程	不是急性大出血的替代治疗
口服补液盐（ORS）	严格按每包规定水量配制	不要自行加浓；持续呕吐时小口频饮
洛哌丁胺（Loperamide）	严格按当地产品标签	血便或明显高热时不要单独使用
茶苯海明（Dimenhydrinate / Gravol）	按当地产品标签；用于晕动症相关恶心/呕吐/眩晕	可明显嗜睡；服后不要驾驶或操作危险设备；避免与酒精/镇静药叠加

10. 疾病 - 药物搭配速查 / Condition-to-Medication Matrix

疾病/症候群	推荐搭配	解释
病毒性上呼吸道感染	对乙酰氨基酚 OR 布洛芬 + 补液 + 鼻腔盐水	不加抗生素
流感 A/B	奥司他韦 + 对乙酰氨基酚 + 口服补液盐（ORS）	抗病毒 + 对症/补液
A 组链球菌咽炎（最好检测确认）	阿莫西林 + 对乙酰氨基酚 OR 布洛芬	不需要为了“更强”自动升级为阿莫西林/克拉维酸
细菌性鼻窦炎	阿莫西林/克拉维酸 + 鼻腔盐水冲洗 + 镇痛	合并过敏性鼻炎可 + 氟替卡松鼻喷
轻型社区获得性肺炎（低风险）	阿莫西林 OR 多西环素 + 支持治疗	“OR”不是一起用
社区获得性肺炎（有基础病/较高风险）	阿莫西林/克拉维酸 + 阿奇霉素 OR 多西环素	需要个人预设用药单；低氧/休克不适合家庭治疗

疾病/症候群	推荐搭配	解释
单纯性膀胱炎	呋喃妥因 OR 复方磺胺甲噁唑 + 补液	无高热/腰痛前提
非化脓性蜂窝织炎	头孢氨苄 OR 阿莫西林/克拉维酸	标记红肿边缘，观察扩展
化脓性脓肿 / MRSA 风险	引流/源控制 + 多西环素 OR 复方磺胺甲噁唑	深部/危险区脓肿不要自行切开
咬伤感染	大量冲洗 + 阿莫西林/克拉维酸	检查破伤风免疫状态
扩散性牙源感染	源控制 + 阿莫西林 OR 阿莫西林/克拉维酸 + 镇痛药	单纯牙痛不等于需要抗生素
水样腹泻	口服补液盐 (ORS) + 洛哌丁胺 (无血/无高热)	补液优先
痢疾 / 发热性腹泻	口服补液盐 (ORS) + 阿奇霉素	不要单用洛哌丁胺
贾第虫病模式	口服补液盐 (ORS) + 甲硝唑 (预授权)	持续、油脂/恶臭便 + 水源暴露更支持
常见肠道蠕虫 (蛲虫/蛔虫/钩虫/鞭虫)	阿苯达唑 (Albendazole) 按虫种预案	蛲虫常需 2 周后重复；不要用于普通腹泻或 Giardia
胃食管/喉咽反流 (GERD/LPR)	海藻酸盐 + 生活方式；或按预案使用埃索美拉唑/法莫替丁	慢性咽痛常见非感染原因
已证实幽门螺杆菌	质子泵抑制剂 + 铋剂 + 四环素 + 甲硝唑 OR 伏诺拉生 + 阿莫西林	完整疗程 + 后续确认根除
过敏性休克	肾上腺素自动注射器 (EpiPen) 立即使用 + 平卧保暖 + 求救/撤离；喘鸣可加沙丁胺醇，西替利嗪仅作皮肤症状辅助	没有口服替代药；沙丁胺醇/抗组胺/泼尼松均不能替代肾上腺素
哮喘急性加重	沙丁胺醇 + 泼尼松 (个人预案)	若合并过敏性休克，立即优先使用肾上腺素自动注射器 (EpiPen) 并同时求救/撤离
过敏性鼻炎 / 鼻后滴流	鼻腔盐水冲洗 + 氟替卡松鼻喷 + 西替利嗪	慢性咽部刺激常随鼻炎改善
体癣/脚癣/股癣	外用克霉唑	不是抗生素问题
中重度接触性皮炎/湿疹 (医生预设)	曲安奈德 0.1% 外用 (Triamcinolone)	仅用于明确非感染性炎症；医生预先限定部位/频率/天数；面部/眼周/生殖器/皱褶区不要自行套用

11A. Rx 预设用药单 - 抗感染药 / Anti-infective Orders

把这一页带给家庭医生/药师：根据两人的过敏史、肾功能、妊娠可能、药物相互作用和既往培养结果，填写实际剂量/频率/疗程。断网时不再临时猜剂量。

阿莫西林 (Amoxicillin)	
启动条件 (医生可修改)	GAS 咽炎 / 低风险 CAP / 牙源感染 (按医生定义)
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

阿莫西林/克拉维酸 (Amoxicillin/Clavulanate)	
启动条件 (医生可修改)	咬伤 / 鼻窦炎 / 牙源 / 部分蜂窝织炎
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

多西环素 (Doxycycline)	
启动条件 (医生可修改)	CAP / MRSA 风险皮肤 / 蜱传病
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

复方磺胺甲噁唑 (TMP-SMX)	
启动条件 (医生可修改)	单纯 UTI / MRSA 风险皮肤
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

阿奇霉素 (Azithromycin)	
启动条件 (医生可修改)	严重旅行者腹泻/痢疾 / CAP 联合
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

奥司他韦 (Oseltamivir)	
启动条件 (医生可修改)	Influenza A/B
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

呋喃妥因 (Nitrofurantoin)	
启动条件 (医生可修改)	单纯性膀胱炎
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

甲硝唑 (Metronidazole)	
启动条件 (医生可修改)	Giardia / 特定厌氧感染
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

头孢氨苄 (Cephalexin)	
启动条件 (医生可修改)	非化脓性蜂窝织炎
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

四环素 (Tetracycline)	
启动条件 (医生可修改)	若采用 H. pylori 优化铋剂四联
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

阿苯达唑 (Albendazole)	
启动条件 (医生可修改)	蛲虫/蛔虫/钩虫/鞭虫的预先确认方案
A: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult A: _____
B: 剂量 x 频率 x 疗程	Adult B: _____
签字	_____

H. pylori 预先选定方案 (只选一套并由医生确认)

方案	组成	个人 Order
优化铋剂四联	质子泵抑制剂 (PPI) + 铋剂 (Bismuth) + 四环素 (Tetracycline) + 甲硝唑 (Metronidazole)	具体剂量/疗程: _____ ____
钾离子竞争性酸阻滞剂 (PCAB) 双联	伏诺拉生 (Vonoprazan) + 阿莫西林 (Amoxicillin)	具体剂量/疗程: _____ ____

11B. Rx 预设用药单 - 急救/支持药 + 禁忌 / Emergency & Supportive Orders

P0 肾上腺素自动注射器 (EpiPen 0.3 mg) : 严重过敏性休克立即使用; 若 5-15 分钟无改善或恶化且有第二支, 可再次使用。建议将两支作为同一应急模块管理。

泼尼松 (Prednisone)	
启动条件	哮喘急性加重 / 医生指定的严重炎症辅助
Adult A Order	Adult A: _____
Adult B Order	Adult B: _____
签字	_____

昂丹司琼口崩片（Ondansetron ODT）	
启动条件	呕吐导致不能进行 口服补液盐（ORS）补液
Adult A Order	Adult A: _____
Adult B Order	Adult B: _____
签字	_____

曲安奈德 0.1% 外用（Triamcinolone 0.1% topical）	
启动条件/医生说明	明确非感染性中重度皮炎/湿疹；医生必须预先写清使用部位、每日次数和最长天数。脸/眼周、腹股沟/生殖器、皮肤皱褶需单独审核。
Adult A：部位/频率/最长天数	Adult A: _____
Adult B：部位/频率/最长天数	Adult B: _____
签字 / 红线	疑似真菌/细菌感染或破溃伤口不要盲涂。

长期处方药中断/减量预案 / Chronic Medication Interruption Plan	
启动条件/医生说明	两名成人的每一种长期处方药都由医生逐药填写：能否骤停；若不能，缺药时的阶梯式减量（Tapering）计划；漏服规则；可否替代；最低安全库存。
Adult A：逐药计划	Adult A: _____
Adult B：逐药计划	Adult B: _____
签字 / 红线	不同药不能套同一减量法；抗凝药、抗癫痫药等不得自行减量/停药。

沙丁胺醇吸入剂（Salbutamol）	
启动条件	支气管痉挛 / 哮喘
Adult A Order	Adult A: _____
Adult B Order	Adult B: _____
签字	_____

埃索美拉唑/质子泵抑制剂（PPI）	
启动条件	GI 出血桥接预案（仅辅助）/ 溃疡或反流
Adult A Order	Adult A: _____
Adult B Order	Adult B: _____
签字	_____

过敏/禁忌快速记录

项目	Adult A	Adult B
青霉素（Penicillin） / β -内酰胺类（beta-lactam）	A: _____	B: _____
磺胺类（Sulfonamide） / 复方磺胺甲噁唑（TMP-SMX）	A: _____	B: _____
QT prolongation / arrhythmia	A: _____	B: _____
Kidney disease / eGFR concern	A: _____	B: _____
Pregnancy possibility	A: _____	B: _____

项目	Adult A	Adult B
Anticoagulant/antiplatelet use	A: _____	B: _____

高频相互作用/误用速查

- 多西环素 (Doxycycline) /四环素 (Tetracycline) 与铁、钙、镁、含铝/镁抗酸剂分开服用；同时服会降低吸收。
- 复方磺胺甲噁唑 (TMP-SMX) 与 血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) /血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) /螺内酯 (spironolactone) 等合用可增加高钾风险，肾功能差时风险更高。
- 阿奇霉素 (Azithromycin) /昂丹司琼 (Ondansetron) 都可能影响 QT；有心律失常史或同时用其他延长 QT 药物时要提前审核。
- 布洛芬 (Ibuprofen) /萘普生 (Naproxen) + GI 出血、脱水、肾病或部分抗凝药 = 风险明显增加。
- 对乙酰氨基酚 (Acetaminophen) 最常见的错误是与复方感冒药重复，导致总剂量超标。
- 次水杨酸铋 (Bismuth subsalicylate) 与 阿司匹林 (Aspirin) 都涉及水杨酸盐；活动性 GI 出血时不要自行叠加。

12. 储存、库存、观察记录与猫模块 / Storage, Inventory, Monitoring & Cat

储存规则 / Storage rules

- 优先储备固体片剂/胶囊，保留原包装、药名、批号、有效期；每 6 个月盘点一次并按最早到期轮换。对两名成人的个人长期处方药，在医生、药房、保险和法规允许时，以约 90 天可轮换库存为灾备目标；不足 90 天时记录实际可用天数并提前续方。
- 大多数固体药：稳定室温、干燥、避光；不要长期放汽车后备箱、潮湿浴室、阁楼或会冻结的车库。
- 口服补液盐 (ORS)、昂丹司琼口崩片、肠溶质子泵抑制剂重点防潮；吸入器避免极端热/冷。肾上腺素自动注射器 (EpiPen) 按标签 15-30°C 室温保存、避光，不冷藏、不冷冻，也不要长期放在炎热车辆内。
- 液体/复溶抗生素通常不适合长期灾备；能储片剂就不储已经加水的悬液。

库存盘点 / Inventory

药物	数量	最早到期
肾上腺素自动注射器 (EpiPen 0.3 mg)	_____	_____
阿莫西林/克拉维酸	_____	_____
多西环素	_____	_____
复方磺胺甲噁唑	_____	_____
阿奇霉素	_____	_____
奥司他韦	_____	_____
阿莫西林	_____	_____
呋喃妥因	_____	_____
甲硝唑	_____	_____
头孢氨苄	_____	_____
阿苯达唑	_____	_____
沙丁胺醇	_____	_____
昂丹司琼	_____	_____
口服补液盐	_____	_____
埃索美拉唑	_____	_____
西替利嗪	_____	_____
氟替卡松鼻喷	_____	_____
洛哌丁胺	_____	_____
对乙酰氨基酚	_____	_____

药物	数量	最早到期
茶苯海明（Dimenhydrinate / Gravol）	_____	_____
曲安奈德 0.1% 外用（Rx）	_____	_____
Adult A 个人长期处方药（目标约 90 天合法轮换库存）	_____	_____
Adult B 个人长期处方药（目标约 90 天合法轮换库存）	_____	_____

生命体征/给药记录 / Vitals & Treatment Log

时间	BP	HR	RR	SpO2	Temp
_____	____/____	_____	_____	____%	____ °C
尿量 / 意识		_____ 症状/给药: _____			

时间	BP	HR	RR	SpO2	Temp
_____	____/____	_____	_____	____%	____ °C
尿量 / 意识		_____ 症状/给药: _____			

时间	BP	HR	RR	SpO2	Temp
_____	____/____	_____	_____	____%	____ °C
尿量 / 意识		_____ 症状/给药: _____			

时间	BP	HR	RR	SpO2	Temp
_____	____/____	_____	_____	____%	____ °C
尿量 / 意识		_____ 症状/给药: _____			

时间	BP	HR	RR	SpO2	Temp
_____	____/____	_____	_____	____%	____ °C
尿量 / 意识		_____ 症状/给药: _____			

猫的基础外伤模块 / Cat basic trauma module

猫用和人用药必须物理分开。基础：生理盐水冲洗、无粘敷料、纱布、Vet Wrap、伊丽莎白圈、止血粉。不要给猫使用人的 对乙酰氨基酚（Acetaminophen）/对乙酰氨基酚（Tylenol）、布洛芬（Ibuprofen）/布洛芬（Advil）或 萘普生（Naproxen）/萘普生（Aleve）；猫的抗菌药、镇痛药和镇静药应由兽医按体重预先制定。

13. 依据与离线备注 / Evidence Base & Offline Notes

- CDC（2025-2026）：A 组链球菌咽炎、成人门诊抗菌、流感抗病毒、急性细菌性鼻窦炎；用于本手册的咽痛/鼻窦炎/流感判断。
- ATS/IDSA + IDSA：成人社区获得性肺炎、皮肤软组织感染、复杂尿路感染；用于肺炎、蜂窝织炎/脓肿、UTI 的首选与升级逻辑。
- ACG（2024）：幽门螺杆菌根除与上消化道出血；PPI/PCAB 为抑酸治疗，活动性高危出血仍需要复苏与内镜止血。
- AAAAI/ACAAI（2023）：过敏性休克；肾上腺素是一线治疗，西替利嗪/糖皮质激素/沙丁胺醇只能辅助。
- WHO + CDC Yellow Book：口服补液盐（ORS）、急性腹泻和旅行者腹泻；补液优先，抗菌药按严重程度和症候群使用。
- CDC（2024-2026）：蛲虫/土源性蠕虫、破伤风伤口管理、一氧化碳中毒；用于阿苯达唑、污染伤口与停电燃烧风险章节。
- ENT Health / NICE / Cleveland Clinic：慢性咽喉不适、鼻后滴流、LPR/GERD、持续声音嘶哑/吞咽困难等红旗。

- AHA / American Red Cross 2024 First Aid + AHA 2025 Adult BLS: 严重出血、开放性胸伤、骨折、脑震荡、脊柱、烧伤、眼外伤、低体温/冻伤/中暑、CPR/AED。
- American College of Surgeons STOP THE BLEED 3.0 (2025) : 直接压迫、伤口填塞、止血带 5-7 cm 高于伤口且避开关节、记录止血带时间。
- NIMH: 惊恐发作可出现心跳快、呼吸急促、胸痛/胸闷、头晕、手脚发麻; 现场以安全环境、减慢呼吸和复评为主。首次或不典型胸痛/呼吸困难不能直接归为惊恐。
- AAAAI + Canadian Lung Association: 过敏性休克与哮喘的识别; 喉舌肿胀、声音改变、喘鸣、晕厥等支持躯体急症, 肾上腺素不能被抗组胺药替代。
- CDC Emergency Water (2026) : 饮水达到持续翻滚沸腾后 1 分钟 (>6500 ft/约 2000 m 为 3 分钟); 5%-9%无香精漂白水清水 2 滴/L, 浑浊、带颜色或很冷的水加倍, 静置至少 30 分钟。
- CDC Norovirus 2025: 呕吐/腹泻污染立即清理; 硬质表面用 1000-5000 ppm 含氯消毒液并保持至少 5 分钟; 肥皂流水洗手至少 20 秒, 免洗手液不能替代。
- King County Public Health + 区域灾害卫生指南: 停水停污水时可用双层垃圾袋 + 猫砂/木屑等吸收材料的桶式厕所; 尿/便分桶可减少废物体积、气味和污染风险。

CDC NIOSH + CDC Yellow Book (2026) : 浸渍足/战壕足可发生在 0-15°C 湿冷环境; 脱湿鞋袜、擦干、抬高、减少行走, 专业旅行医学资料强调干燥被动回温并避免快速主动回温。

CDC STI Treatment Guidelines: 无并发症外阴阴道念珠菌病可用局部克霉唑 (Clotrimazole) 或预设口服氟康唑 (Fluconazole) ; 有症状细菌性阴道病常用甲硝 (Metronidazole) , 但单靠症状不能可靠区分所有阴道炎。

CDC Conjunctivitis (2024) : 病毒性结膜炎通常不需要抗生素; 细菌性结膜炎在脓性分泌物等情况下可考虑局部抗生素; 手卫生、分开毛巾/枕巾/眼药水和停止揉眼是阻断传播核心。

American Academy of Ophthalmology EyeWiki : 光照性角膜炎/雪盲以停止 UV 暴露、人工泪液和口服止痛等支持治疗为主, 角膜表面通常 24-72 小时恢复; 不推荐常规紧密包眼。

- Health Canada topical corticosteroid safety: 中强效外用激素应限制部位和疗程, 面部/生殖器薄皮区域及感染性皮炎需特别谨慎。
- AAFP/常规裂伤处理原则: 免缝胶带适用于清洁、低张力、边缘可轻松合拢的伤口; 咬伤、刺伤、感染/重污染伤不应强行闭合。
- Health Canada Dimenhydrinate Labelling Standard: 茶苯海明用于晕动症相关恶心、呕吐与头晕; 需警惕嗜睡和驾驶/操作设备风险。

给非医学背景使用者的最后 7 条规则

- 1. 严重大出血、气道/呼吸问题、过敏性休克、休克/意识异常 > 精确诊断。先处理生命威胁。
- 2. 发热不等于需要抗生素; 黄痰/绿鼻涕也不等于细菌感染。
- 3. 看到“OR”就只选一个; 只有明确写“+”才代表联合。
- 4. 已启动的处方抗菌疗程不要因为 1 天内没有完全退烧就随意换药或叠加第二种; 看趋势和危险信号。
- 5. 慢性咽喉不适重点是找原因 (鼻炎/鼻后滴流、反流、干燥、刺激物等) , 不是长期反复吃阿莫西林 (Amoxicillin) 。
- 6. 不确定时, 先做支持治疗和监测, 不要用“广谱抗生素试试看”代替判断。
- 7. 所有治疗都要复评; 任何明显恶化都比“有没有吃完药”更重要。外伤稳定后仍要反复看意识、呼吸、循环、止血和肢体血流。

建议打印方式: Letter 竖向 (Portrait)、双面、100%比例。v17 在 v16 基础上新增: 茶苯海明 (Dimenhydrinate / Gravol)、Dentemp/氧化锌类临时补牙材料、Steri-Strips + 复方安息香酊、重力净水器前置过滤、约 90 天个人长期处方药轮换库存目标、Rx 曲安奈德 0.1% 外用及联合/错峰镇痛安全卡; 开源版另加入儿童/婴儿用药绝对禁区与长期处方药中断/减量预案。既有实物 IFAK、浸渍足/战壕足、女性卫生/TSS、雪盲与非创伤性眼科模块继续保留。